



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI LAYANAN KEBIDANAN

Ummy Yuniantini • Ratna Diana Fransiska
Cut Sriyanti • Warini

Editor: Eva Zulisa



BUNGA RAMPAI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI LAYANAN KEBIDANAN

Penulis:

Ummy Yuniantini, S.ST., M.Keb.
Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.
Dr. Cut Sriyanti, SST, M.Keb.
Warini, S.ST., M.KM.

Editor:

Eva Zulisa, S.ST., M.Tr.Keb.



Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan

Penulis: Ummy Yuniyanti, S.ST., M.Keb.

Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.

Dr. Cut Sriyanti, SST, M.Keb.

Warini, S.ST., M.KM.

Editor: Eva Zulisa, S.ST., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-34-3

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan ini. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya dalam konteks kesehatan ibu dan anak, serta pentingnya peran layanan kebidanan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Buku ini disusun secara sistematis oleh para akademisi dan praktisi kebidanan yang memiliki perhatian dan pengalaman luas di bidang kesehatan ibu dan anak, dengan harapan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang masing-masing mengangkat tema penting dalam pemberdayaan perempuan melalui perspektif kebidanan. Bab pertama membahas tantangan global dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta solusi yang relevan. Bab kedua mengangkat pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi efektif dalam mengatasi isu kesehatan ibu dan anak di berbagai wilayah. Bab ketiga fokus pada peningkatan kesadaran kesehatan ibu hamil melalui pendidikan, teknologi, dan dukungan sosial. Sementara bab keempat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua penulis, editor, dan pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memperkaya wawasan serta mendorong langkah nyata dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui layanan kebidanan. Besar harapan kami bahwa buku ini menjadi pijakan dalam praktik kebidanan yang lebih humanistik, inklusif, dan berbasis bukti. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 TANTANGAN GLOBAL DALAM PENINGKATAN KESEHATAN

IBU DAN ANAK.....	1
Ummy Yuniyanti, S.ST., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Tantangan Global dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak.....	1
C. Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Tantangan	7
D. Kesimpulan.....	12
E. Referensi	13
F. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK KESEHATAN

IBU DAN ANAK.....	17
Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Konsep Pendekatan Berbasis Komunitas.....	18
C. Peran Bidan dalam Pendekatan Berbasis Komunitas	23
D. Strategi Implementasi Pendekatan Berbasis Komunitas	25
E. Studi Kasus: Keberhasilan Program Berbasis Komunitas di Dunia.....	27
F. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Berbasis Komunitas.....	30
G. Kesimpulan.....	33
H. Referensi	34

CHAPTER 3 STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN IBU

HAMIL.....	37
Dr. Cut Sriyanti, SST, M.Keb.	37
A. Pendahuluan/Prolog	37
B. Pendidikan Prenatal.....	43
C. Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan Kesehatan.....	46
D. Penguatan Sistem Dukungan Keluarga dan Masyarakat.....	48
E. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Ibu Hamil	49

F. Simpulan	50
G. Referensi	50
H. Glosarium.....	53

CHAPTER 4 KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN55

Warini, S.ST., M.KM.....	55
A. Pendahuluan/Prolog	55
B. Kajian Pemberdayaan Perempuan	56
C. Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan Perempuan	64
D. Simpulan	68
E. Referensi	69
F. Glosarium.....	73

PROFIL PENULIS75

CHAPTER 1

TANTANGAN GLOBAL DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Ummy Yuniyanti, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kemakmuran suatu bangsa dapat tercermin dari tingkat kesehatan ibu dan anak yang dimilikinya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, permasalahan global yang muncul justru semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani. Kondisi kesehatan yang bervariasi di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang, semakin diperparah oleh meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi serta masih rendahnya angka kelangsungan hidup ibu dan bayi.

Selain itu, perubahan iklim, bencana alam, dan pandemi turut berkontribusi dalam memperburuk aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang memadai pada saat dibutuhkan. Tantangan lain yang juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak meliputi keterbatasan infrastruktur kesehatan, kurangnya informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, serta minimnya tenaga medis yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara sektor publik, swasta, serta lembaga pemerintahan di tingkat global untuk merancang solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam pembahasan ini, akan dikaji beberapa kendala utama dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

B. Tantangan Global dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama dalam agenda kesehatan global. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada tantangan yang menghambat pencapaian target kesehatan ibu dan anak, terutama di negara-negara berkembang. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Di banyak negara berkembang, akses terhadap layanan kesehatan maternal dan neonatal masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Kurangnya fasilitas kesehatan, tenaga medis yang terbatas, serta infrastruktur

yang buruk menjadi hambatan utama bagi ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, berdasarkan berbagai sumber jurnal dan literatur akademik:

a. Teori Akses ke Layanan Kesehatan (Penchansky & Thomas, 1981)

Penchansky dan Thomas (1981) mengembangkan konsep **lima dimensi aksesibilitas layanan kesehatan**, yaitu:

- 1) **Availability (Ketersediaan):** Apakah sumber daya kesehatan seperti fasilitas, tenaga medis, dan obat-obatan mencukupi?
- 2) **Accessibility (Aksesibilitas):** Sejauh mana lokasi fasilitas kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat, baik dari segi jarak maupun transportasi?
- 3) **Affordability (Keterjangkauan):** Apakah layanan kesehatan dapat diakses secara finansial oleh semua kelompok masyarakat?
- 4) **Acceptability (Dapat Diterima):** Apakah layanan kesehatan sesuai dengan nilai budaya dan sosial masyarakat?
- 5) **Accommodation (Akomodasi):** Sejauh mana layanan kesehatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, seperti jam operasional dan sistem pendaftaran?

Teori ini menyoroti bahwa keterbatasan akses tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh faktor ekonomi, budaya, dan sosial.

b. Model Andersen Behavioral Model of Health Services Use (1995)

Andersen mengembangkan model perilaku penggunaan layanan kesehatan yang terdiri dari tiga faktor utama:

- 1) **Predisposing Factors (Faktor Predisposisi):** Faktor individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi keputusan untuk mencari layanan kesehatan.
- 2) **Enabling Factors (Faktor Kemampuan):** Faktor-faktor yang memungkinkan atau menghambat seseorang untuk mengakses layanan kesehatan, seperti pendapatan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan ketersediaan fasilitas.
- 3) **Need Factors (Faktor Kebutuhan):** Tingkat kebutuhan medis seseorang berdasarkan kondisi kesehatan mereka.

Model ini menjelaskan bahwa keterbatasan akses terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan medis tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup atau faktor pendukung lainnya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

c. Teori Social Determinants of Health (WHO, 2008)

Menurut World Health Organization (WHO), **determinasi sosial kesehatan** mencakup faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial yang

memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keterbatasan akses kesehatan meliputi:

- 1) **Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi** yang membatasi kemampuan seseorang untuk membayar layanan kesehatan.
- 2) **Kesenjangan pendidikan** yang mempengaruhi pengetahuan tentang pentingnya perawatan kesehatan.
- 3) **Lingkungan fisik yang tidak mendukung**, seperti daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
- 4) **Norma sosial dan budaya** yang membatasi kelompok tertentu (misalnya perempuan di beberapa budaya) dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Teori ini menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan tidak hanya masalah individu tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan.

d. Teori Sistem Kesehatan (Donabedian, 1980)

Donabedian mengembangkan teori yang berfokus pada **struktur, proses, dan hasil layanan kesehatan** dalam menilai kualitas dan akses layanan kesehatan:

- 1) **Struktur**: Meliputi sumber daya kesehatan, tenaga medis, infrastruktur, dan kebijakan yang tersedia.
- 2) **Proses**: Interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, seperti ketersediaan konsultasi, prosedur medis, dan keterampilan tenaga medis.
- 3) **Hasil**: Kesehatan masyarakat secara keseluruhan setelah mendapatkan layanan kesehatan.

Keterbatasan akses terjadi ketika terdapat ketimpangan dalam struktur dan proses layanan kesehatan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kesehatan masyarakat.

e. Teori Equity in Access to Healthcare (Goddard & Smith, 2001)

Goddard dan Smith berpendapat bahwa akses terhadap layanan kesehatan harus **adil** (equitable) dan bukan hanya **sama rata** (equal). Mereka membedakan antara:

- 1) **Horizontal Equity**: Orang dengan kebutuhan kesehatan yang sama harus mendapatkan layanan yang sama, tanpa adanya hambatan ekonomi atau geografis.
- 2) **Vertical Equity**: Orang dengan kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi harus mendapatkan lebih banyak sumber daya kesehatan dibandingkan mereka yang kurang membutuhkan.

Ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan sering terjadi akibat kesenjangan sosial, geografis, dan ekonomi, yang menyebabkan kelompok rentan lebih sulit mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan berbagai teori di atas, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, geografis, dan kebijakan. Untuk meningkatkan aksesibilitas, diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan peningkatan infrastruktur kesehatan, kebijakan inklusif, serta penguatan ekonomi dan edukasi masyarakat.

2. Angka Kematian Ibu dan Anak yang Masih Tinggi

Tingkat kematian ibu (Maternal Mortality Rate/MMR) dan tingkat kematian bayi (Child Mortality Rate/CMR) merupakan indikator fundamental dalam menilai kualitas sistem layanan kesehatan suatu negara. Meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam sektor kesehatan, angka kematian ibu dan bayi masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia.

a. Angka Kematian Ibu (AKI) Global

Berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2020 tercatat lebih dari 287.000 perempuan meninggal dunia selama atau segera setelah proses persalinan. Angka ini menunjukkan bahwa setiap harinya terdapat hampir 800 perempuan yang kehilangan nyawa akibat komplikasi yang timbul selama masa kehamilan atau persalinan. Sebagian besar kasus kematian ibu terjadi di negara berkembang, terutama di kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu antara lain perdarahan hebat, infeksi pasca persalinan, preeklamsia dan eklampsia, komplikasi selama proses persalinan, serta praktik aborsi yang tidak aman.

b. Angka Kematian Ibu di Indonesia

Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia masih memiliki angka kematian ibu yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020, angka kematian ibu mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam konteks ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua dengan tingkat MMR tertinggi, berada di bawah Vietnam, Brunei, Thailand, dan Malaysia. Selain itu, angka kematian ibu di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat MMR di Papua mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Papua Barat angkanya mencapai 343 per 100.000 kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Anak (AKB) Global

Indikator lain yang menunjukkan kecenderungan menurun adalah tingkat kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR). Meskipun demikian, pada tahun 2019 tercatat sekitar 2,4 juta bayi meninggal dunia secara global. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian bayi antara lain komplikasi akibat kelahiran prematur, hipoksia neonatal, infeksi, serta kelainan bawaan.

d. Angka Kematian Anak di Indonesia

Di Indonesia, tingkat kematian bayi juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan laporan BPS, angka kematian bayi pada tahun 2020 mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun angka ini menandakan adanya perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih diperlukan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu menurunkan angka kematian bayi hingga mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

3. Kesenjangan Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan

Kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan merupakan isu krusial yang mempengaruhi kualitas hidup dan stabilitas suatu negara. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut, disertai data terkini dari dunia dan Indonesia.

a. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi mengacu pada perbedaan distribusi pendapatan dan kekayaan antarindividu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ini adalah Koefisien Gini, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

- 1) **Global:** Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2023, sekitar 9% populasi dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, atau setara dengan pendapatan kurang dari \$2 per hari.
- 2) **Indonesia:** Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 9,57% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Gini Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 0,385, mencerminkan tingkat ketimpangan yang cukup signifikan.

b. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial berkaitan dengan perbedaan akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang yang mempengaruhi kualitas hidup individu atau kelompok.

- 1) **Global:** Studi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di 36 negara yang disurvei menganggap kesenjangan antara kaya dan miskin sebagai masalah besar.
- 2) **Indonesia:** Kesenjangan sosial di Indonesia kian memprihatinkan, dengan faktor ekonomi dan pendidikan sebagai kontributor utama. Tingginya biaya pendidikan tinggi dan kualitas sekolah di daerah tertinggal yang masih jauh di bawah standar memperparah kesenjangan ini.

c. Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan merujuk pada perbedaan akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok, seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geografis.

- 1) **Global:** Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di banyak negara, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
- 2) **Indonesia:** Kesenjangan pendidikan di Indonesia masih signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor seperti susah akses menuju sekolah, kurangnya fasilitas sekolah, rendahnya minat dan kualitas guru, serta perspektif terhadap pendidikan berkontribusi terhadap kesenjangan ini.

4. Pengaruh Krisis Global (Perubahan Iklim, Konflik, dan Pandemi)

Krisis global seperti perubahan iklim, konflik, dan pandemi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, baik di tingkat global maupun di Indonesia.

a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dampaknya meliputi penurunan produksi pertanian, kelangkaan air bersih, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Di Indonesia, perubahan iklim berkontribusi pada peningkatan kejadian bencana seperti banjir dan kekeringan, yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan.

b. Konflik

Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik mengakibatkan krisis kemanusiaan, migrasi paksa, dan gangguan terhadap sistem ekonomi dan pendidikan. Meskipun Indonesia relatif stabil, dampak konflik di negara lain dapat mempengaruhi Indonesia melalui arus pengungsi, gangguan perdagangan, dan ancaman keamanan regional.

c. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan global dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan.

- 1) Global: Pandemi menyebabkan gangguan ekonomi global, peningkatan angka pengangguran, dan tekanan pada sistem kesehatan di banyak negara.
- 2) Indonesia: Pandemi berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07%, pertama kalinya sejak krisis moneter 1998. Sektor pariwisata dan UMKM terdampak paling parah, dengan banyak usaha terpaksa tutup dan pekerja kehilangan mata pencaharian. Selain itu, sistem kesehatan menghadapi tekanan besar dengan lonjakan kasus COVID-19, terutama selama puncak gelombang infeksi.

Dalam menghadapi krisis global ini, diperlukan kerjasama internasional dan kebijakan nasional yang adaptif untuk memitigasi dampak negatif serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman serupa di masa depan.

C. Upaya dan Solusi dalam Mengatasi Tantangan

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berbagai strategi dan pendekatan telah diterapkan guna meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang telah diimplementasikan:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah telah memperluas cakupan layanan kesehatan maternal bagi jutaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, program berbasis komunitas seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga telah berkontribusi dalam peningkatan pembiayaan untuk perawatan prenatal.

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai inisiatif telah dikembangkan dengan solusi berikut:

a. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Salah satu regulasi yang mendukung upaya ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur layanan kesehatan mulai dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, hingga pasca-persalinan. Regulasi ini juga mencakup akses terhadap layanan kontrasepsi serta kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

b. Peningkatan Akses melalui Program Asuransi Kesehatan Nasional

Melalui program JKN, cakupan layanan kesehatan maternal telah diperluas, terutama di daerah terpencil dan kurang terjangkau. Program ini memungkinkan jutaan masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan bayi yang sebelumnya sulit dijangkau.

c. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran publik mengenai pentingnya perawatan kesehatan prenatal dan pediatrik terus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi. Penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk mengurangi kejadian penyakit yang dapat dicegah serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

d. Peningkatan Mutu Layanan di Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan garda terdepan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan, serta optimalisasi ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

e. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) diawasi melalui sistem Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA). Selain itu, sejak tahun 2012, program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) telah dijalankan guna mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

f. Kolaborasi Antar Sektor

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak dapat dicapai melalui kerja sama antara sektor publik, swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kemitraan ini mencakup pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penyebaran informasi mengenai pentingnya layanan kesehatan maternal dan neonatal.

Melalui implementasi strategi-strategi ini, diharapkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dapat ditekan secara signifikan, seiring dengan meningkatnya akses serta kualitas layanan kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah.

2. Penguatan Fasilitas Kesehatan Primer

“Banyak negara mengembangkan dan memperkuat klinik kesehatan komunitas untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2023, akan ada 10.180 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang menyediakan layanan seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan program pengendalian penyakit menular.

Penguatan fasilitas kesehatan primer merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Fasilitas kesehatan primer, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Berikut ini adalah upaya dan solusi yang telah dan sedang dilakukan untuk memperkuat fasilitas kesehatan primer,

a. Revitalisasi dan Standarisasi Puskesmas

Pemerintah Indonesia telah melakukan revitalisasi jaringan dan standarisasi layanan di Puskesmas, Posyandu, dan melalui kunjungan rumah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada ibu dan anak.

b. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

Upaya keterpaduan pelayanan kesehatan primer dilakukan dengan menyelenggarakan dan mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Sebagai contoh, Puskesmas Ngabang telah melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerjanya.

c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui penguatan kompetensi para kader posyandu yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Berau, misalnya, kader

kesehatan diharapkan memiliki 25 kompetensi dasar untuk meningkatkan layanan kesehatan primer.

d. Orientasi dan Pelatihan bagi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan di berbagai provinsi mengadakan orientasi layanan primer bagi Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan primer. Di Kalimantan Tengah, misalnya, telah dilakukan orientasi layanan primer bagi Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

e. Peningkatan Akses Layanan Imunisasi

Penguatan upaya preventif di layanan kesehatan primer juga dilakukan dengan meningkatkan akses pada layanan imunisasi. Hal ini penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yang berperan dalam menurunkan angka kematian anak.

f. Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan

Pemerintah mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan primer, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan fasilitas kesehatan primer di Indonesia dapat semakin tangguh dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi ibu dan anak, sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan."

3. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan

Perawat dan bidan, bersama dengan tenaga kesehatan lainnya, berpartisipasi dalam pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani tantangan unik yang muncul selama masa kehamilan dan persalinan. Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan bagi ibu dan anak, pemerintah menyelenggarakan berbagai program pelatihan. Selain itu, penyelenggaraan layanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah kehamilan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan menjadi aspek yang sangat krusial. Berikut adalah beberapa inisiatif dan solusi yang telah diterapkan di berbagai negara:

a. Inisiatif Agbebiye di Nigeria

Pada tahun 2014, pemerintah Negara Bagian Ondo di Nigeria meluncurkan program Agbebiye, yang dalam bahasa Yoruba berarti "pendamping persalinan yang aman". Program ini bertujuan untuk meningkatkan rujukan ibu hamil ke fasilitas kesehatan formal dengan memberikan pelatihan kepada para dukun beranak tradisional serta organisasi keagamaan. Berkat inisiatif ini, angka kematian ibu mengalami penurunan signifikan, dari 745 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 112 per 100.000 pada tahun 2016, mencerminkan penurunan sebesar 84,9%.

b. Platform e-Kesehatan SATMED

SATMED merupakan sebuah platform e-health yang memanfaatkan teknologi satelit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Sistem ini memungkinkan tenaga medis dan bidan di Benin untuk terhubung dengan tenaga kesehatan global guna memperoleh pelatihan jarak jauh. Melalui platform ini, kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak di wilayah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.

c. Proyek SUSA di Uni Eropa

Program SUSA di Uni Eropa Didukung oleh pendanaan sebesar €12,4 juta dari inisiatif Digital Europe Uni Eropa, program Sustainable Healthcare with Digital Health Data Competence (SUSA) merupakan hasil kolaborasi dari 12 institusi di Eropa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, melalui kurikulum pendidikan tingkat sarjana, pascasarjana, serta pembelajaran sepanjang hayat. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan dan keterlibatan digital dalam layanan kesehatan, dengan melibatkan tenaga kesehatan sejak tahap awal pengembangan teknologi.

d. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia

Untuk memastikan tenaga kesehatan di Indonesia memiliki kesiapan yang optimal dalam memberikan layanan bagi ibu dan anak, pemerintah telah menerapkan berbagai program pelatihan. Regulasi terkait, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2021, mencakup aspek layanan kesehatan prenatal, proses persalinan, serta perawatan pascapersalinan. Implementasi program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan.

4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, berbagai program edukasi telah digalakkan guna menekankan

pentingnya perawatan prenatal, persalinan yang aman, serta perawatan bayi. Pemerintah, bersama dengan UNICEF, turut berupaya memastikan bahwa seluruh anak, terutama yang berada dalam kondisi rentan, memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan berkualitas. Upaya ini mencakup perencanaan program yang terstruktur, penyusunan anggaran yang komprehensif, serta perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Diyakini bahwa melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan melalui implementasi kebijakan dan strategi yang efektif.

5. Monitoring dan Evaluasi Program

Penggunaan data dan indikator kesehatan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program kesehatan ibu dan anak, memungkinkan penyesuaian kebijakan yang tepat waktu.

Kementerian Kesehatan menetapkan peningkatan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja sebagai salah satu program prioritas. Upaya ini mencakup perbaikan gizi masyarakat serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan program kesehatan ibu dan anak dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Permasalahan kesehatan global yang paling mendesak, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, masih menjadi hambatan signifikan bagi kemajuan pembangunan di berbagai negara. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator kesehatan, pencapaian target kesehatan secara menyeluruh masih menghadapi tantangan besar, sebagaimana ditunjukkan oleh data terkini.

Salah satu kendala utama yang masih menjadi perhatian serius adalah tingginya angka kematian ibu (AKI). Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Penduduk Long Form tahun 2020, angka kematian ibu di Indonesia tercatat sebesar 173 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini mengindikasikan bahwa target penurunan AKI masih belum dapat direalisasikan secara optimal.

Selain itu, kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sebagian perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Hambatan ini terutama dirasakan di daerah terpencil, di mana faktor geografis dan keterbatasan finansial sering kali menjadi kendala utama dalam memperoleh layanan medis yang diperlukan.

Sebagai respons terhadap permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, berbagai inisiatif strategis telah diimplementasikan guna meningkatkan kualitas serta aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah secara aktif memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui program berbasis komunitas, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan dukungan finansial untuk memastikan pemeriksaan kehamilan dan perawatan prenatal dapat dilakukan secara berkala. Selain itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan terus menjadi prioritas dengan meningkatkan kapasitas fasilitas medis, menjamin ketersediaan obat-obatan esensial, serta menyediakan peralatan medis yang lebih lengkap agar perawatan bagi ibu dan bayi dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek fundamental dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, terutama melalui penyuluhan mengenai pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat serta penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran.

Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, tingginya angka kematian ibu serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, tenaga medis, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Andersen, R.M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), pp.1–10.
- Astuti, Y. dan Widayatun. (2020). Menuju Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Astuti, Y. dan Widayatun. (2021). Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Astutiningsih. (2024). Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak: Inovasi untuk Masyarakat Sehat. Yogyakarta: Trans Medika.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate/MMR) hasil long form SP2020 menurut provinsi, 2020. Available at: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxOSMx/angka-kematian-ibu-aki-maternal-mortality-rate-mmr-hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi-2020.html?utm_source [Accessed 2024].

- Donabedian, A. (1980). Explorations in quality assessment and monitoring. Volume I: The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, MI: Health Administration Press.
- Goddard, M. and Smith, P. (2001). Equity of access to health care services: Theory and evidence from the UK. *Social Science & Medicine*, 53(9), pp.1149–1162.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023). Agar ibu dan bayi selamat. Available at: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/?utm_source [Accessed 2024].
- Kompas.com (2024). Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Available at: https://www.kemennppa.go.id/page/view/NDg3NA%3D%3D?utm_source [Accessed 2024].
- Menendez, C., Gonzalez, R., Donnay, F. dan Leke, R.G.F. (2020). Avoiding indirect effects of COVID-19 on maternal and child health. *The Lancet Global Health*, 8(7), hlm. e863–e864.
- Molgora, S. dan Accordini, M. (2020). Motherhood in the time of Coronavirus: The impact of the pandemic emergency on expectant and postpartum women's psychological well-being. *Frontiers in Psychology*, 11, hlm. 1–16.
- Moyer, C., Compton, S., Kaselitz, E. dan Muzik, M. (2020). Pregnancy-related anxiety during COVID-19: A nationwide survey of 2,740 pregnant women. *Archives of Women's Mental Health*, 23(6), hlm. 757–765.
- Penchansky, R. and Thomas, J.W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), pp.127–140.
- Ravaldi, C., Wilson, A., Ricca, V., Homer, C. dan Vannacci, A. (2020). Pregnant women voice their concerns and birth expectations during the COVID-19 pandemic in Italy. *Women and Birth*, 34(4), hlm. 335–343.
- Saputri, N.S., Anbarani, M.D., Toyamah, N. dan Yumna, A. (2020). Dampak pandemi COVID-19 pada layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA): Studi kasus di lima wilayah di Indonesia. *The SMERU Research Institute*, 5, hlm. 1–8.
- United Nations Population Fund (UNFPA) (2020). Mortalitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
- Wijayanti, I.T., Adhianata, H., Jamal, R.S., Sari, N.K.Y., Widiyastuti, N.E., Rahmania, T., Astuti, D.W., Agustini, N.K.T., Fransiska, P., Christiana, I., Anggriani, G., Stefani, M., Nur, A.F., Fadlina, A., Marfu'ah, S. dan Humayrah, W. (2023). *Pengantar Kesehatan Ibu dan Anak*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka.
- World Health Organization (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing, 13(6), pp.1–44. Available at: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing.

World Health Organization (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: WHO.

Yani, V.D., Emilia, O. and Kusnanto, H. (2014). Persepsi remaja terhadap faktor penghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), pp.34–45. Available at: <https://doi.org/10.22146/jkr.4913>.

F. Glosarium

Aksesibilitas – Kemudahan individu dalam mendapatkan layanan kesehatan berdasarkan faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya.

AKB (Angka Kematian Bayi) – Jumlah kematian bayi sebelum usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

AKI (Angka Kematian Ibu) – Jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan, atau nifas per 100.000 kelahiran hidup.

Asfiksia Lahir – Kondisi di mana bayi tidak mendapat cukup oksigen saat lahir, yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan jangka panjang.

COVID-19 – Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang berdampak pada sistem pernapasan dan memiliki efek luas terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.

Determinan Sosial Kesehatan – Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu dan kelompok masyarakat.

Donabedian Model – Model evaluasi kualitas layanan kesehatan yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil.

Ekuitas dalam Akses Kesehatan – Prinsip yang menyatakan bahwa semua individu harus mendapatkan layanan kesehatan yang setara sesuai kebutuhan mereka, tanpa diskriminasi.

Evidence-Based Practice (EBP) – Praktik kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Program asuransi kesehatan pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Kesehatan Maternal dan Neonatal – Bidang kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan, serta kesehatan bayi baru lahir.

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi – Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, pendapatan, dan akses terhadap layanan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) – Program yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak guna mengurangi angka kematian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kontrasepsi – Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan mengatur kelahiran.

Layanan Kesehatan Primer – Layanan kesehatan dasar yang diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas dan klinik.

Malnutrisi – Kondisi kekurangan atau kelebihan gizi yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak.

Mortalitas Ibu – Kematian ibu akibat kehamilan atau persalinan dalam periode tertentu.

Neonatus – Bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari pertama kehidupan.

Pandemi – Wabah penyakit yang terjadi secara luas di berbagai negara atau benua dan berdampak pada kesehatan masyarakat global.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi – Layanan yang mencakup kesehatan seksual, keluarga berencana, perawatan kehamilan, dan persalinan yang aman.

Penyebab Kematian Ibu – Faktor utama yang menyebabkan kematian ibu melahirkan, seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, infeksi, dan komplikasi persalinan.

PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat-Kesehatan Ibu dan Anak) – Sistem monitoring untuk memantau cakupan dan efektivitas program kesehatan ibu dan anak di wilayah tertentu.

Sustainable Development Goals (SDGs) – Tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagai salah satu target utamanya.

UNICEF (United Nations Children's Fund) – Organisasi internasional yang fokus pada kesejahteraan anak-anak dan ibu di seluruh dunia.

WHO (World Health Organization) – Organisasi Kesehatan Dunia yang memberikan panduan global mengenai kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak.

CHAPTER 2

PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS UNTUK KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH.

A. Pendahuluan

Saat ini kita berada pada masa di mana era Tujuan Pembangunan Milenium PBB (*Millenium Development Goals/MDGs*) telah berakhir (2000-2015) dan era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) telah dimulai (2015-2030). Meskipun kemajuan besar telah dicapai di seluruh dunia dalam mengurangi angka kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak, namun sebesar 8,8 juta kematian ibu, bayi lahir mati, bayi baru lahir, dan anak usia 1-59 bulan terjadi setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah atau diobati. Hanya empat dari 75 negara di dunia mampu mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 4 yang menyerukan pengurangan dua pertiga kematian balita pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 1990, dan MDG 5 yang menyerukan pengurangan tiga perempat kematian ibu. Salah satu alasan penting dari hasil yang mengecewakan ini adalah kegagalan dalam mengimplementasikan dan memperluas intervensi berbasis masyarakat yang berbasis bukti (Perry, Rassekh, Gupta, Wilhelm, et al., 2017).

Semua perempuan berhak mendapatkan pelayanan yang membuat mereka merasa dihargai (*respectful care*), peka terhadap budaya, dan berpusat pada perempuan (*woman centered care*) yang mempertimbangkan bagaimana, di mana, dan dengan siapa mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan hal ini terjadi, sistem kesehatan harus bisa menjangkau perempuan dimanapun mereka berada baik dalam arti harfiah maupun kiasan. Pendekatan berbasis masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif untuk menyediakan layanan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh perempuan di tempat yang mereka pilih. Sayangnya, banyak sistem kesehatan saat ini tidak memiliki kapasitas atau infrastruktur untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas di tingkat komunitas. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan yang kuat dan terlatih, sistem rujukan dan transportasi yang efisien serta infrastruktur fisik yang memadai. Namun demikian, sejumlah program telah memberikan pelayanan *antenatal*, *intrapartum* dan *postpartum* di tingkat masyarakat. Banyak dari program-

program ini, terutama yang dilaksanakan di daerah pedesaan dengan minimnya tenaga kesehatan, telah melibatkan pengalihan tugas dengan menggunakan tenaga kesehatan masyarakat (*community health workers*) (Hodin S, 2017). Intervensi berbasis masyarakat akan menjadi komponen penting dalam pendekatan komprehensif komprehensif untuk mempercepat peningkatan kesehatan ibu dan mengakhiri kematian ibu yang dapat dicegah kematian ibu yang dapat dicegah pada tahun 2030 (Jennings et al., 2017).

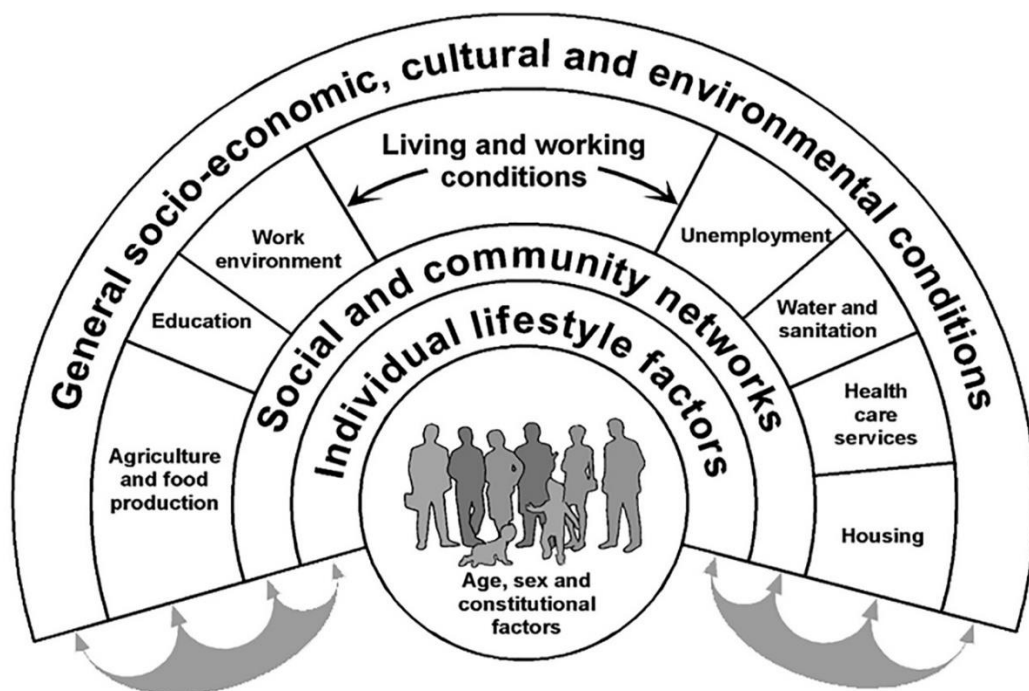
B. Konsep Pendekatan Berbasis Komunitas

Kesehatan adalah kunci untuk mencapai potensi seseorang dalam hidup. Kesehatan juga sangat penting bagi semua orang. Kesehatan dapat dianggap sebagai investasi yang sangat membantu pembangunan negara. Piagam Ottawa tahun 1986 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia (*human right*). Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan program pembangunan kesehatan adalah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut teori Blum (1974), ada empat komponen yang berkontribusi pada tingkat kesehatan seseorang yaitu gaya hidup, lingkungan (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), pelayanan kesehatan dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor ini berdampak pada kesehatan seseorang karena berinteraksi satu sama lain. Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi besar terhadap kesehatan seseorang adalah kualitas pelayanan kesehatan. Tingkat kesehatan individu dalam populasi ditentukan oleh banyak faktor yang tersebar di berbagai level. Pelayanan kesehatan biasanya menjadi perhatian utama, tetapi itu bukanlah satu-satunya faktor penting. Pelayanan kesehatan hanya salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan seseorang (Ridlo et al., 2019).

Dhalgren dan Whitehead (1991) membahas teori determinan sosial kesehatan, yang menjelaskan bahwa berbagai komponen lingkungan memengaruhi kesehatan seseorang. Dalam model pelangi determinan sosial kesehatan, status kesehatan individu atau masyarakat digambarkan sebagai setengah lingkaran berlapis, dengan sebagian besar determinan kesehatan dapat diubah. Faktor genetik, sistem lingkungan, dan individu yang ingin meningkatkan kesehatannya adalah yang paling penting (Ridlo et al., 2019). Pengaruh sosial dan komunitas di lapisan kedua terdiri dari norma komunitas, prinsip, institusi, modal, dan jejaring sosial. Faktor-faktor sosial di tingkat komunitas dapat membantu anggota komunitas mendapatkan kondisi kesehatan yang baik. Lapisan ketiga terdiri dari komponen

struktural seperti lingkungan pemukiman yang baik, ketersediaan makanan, ketersediaan energi, kondisi tempat bekerja, kondisi sekolah, ketersediaan air bersih dan sanitasi, akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, akses ke pendidikan yang berkualitas tinggi, dan lapangan kerja yang layak. Lapisan terluar meliputi kebijakan publik, stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, hubungan internasional, investasi dalam pembangunan ekonomi, peperangan dan perdamaian, perubahan iklim dan cuaca, ekosistem, bencana alam dan bencana buatan manusia. Lapisan terluar juga mencakup lingkungan fisik dan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan politik secara keseluruhan (Ridlo et al., 2019).



Source: adapted from Dahlgren and Whitehead, 1991

Gambar 2.1: Model Determinan Ekologi Sosial Kesehatan Dahlgren dan Whitehead (1991)

Berdasarkan model determinan ekologi sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead (1991), untuk mencapai kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal, diperlukan beberapa hal: 1) mencapai potensi penuh seseorang, yang mencakup potensi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan ekonomi; 2) memenuhi harapan peran seseorang dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja; dan 3) menerapkan kebijakan makro. Ada kemungkinan bahwa penanggulangan yang hanya berkonsentrasi pada faktor risiko pada tingkat individu tidak akan menghasilkan dampak yang optimal. Faktor penyebab pada tingkat sosial harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Di sisi kebijakan, ini berarti bahwa kebijakan yang efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan

kesehatan masyarakat dan komunitas serta menciptakan pemerataan pembangunan kesehatan (Ridlo et al., 2019).

Program kesehatan berbasis komunitas (*Community-Based Primary Health Care/CBPHC*) dapat memperluas cakupan layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga. Para Ahli merekomendasikan bahwa CBPHC harus menjadi prioritas untuk memperkuat sistem kesehatan, mempercepat kemajuan dalam mencapai cakupan kesehatan universal (*universal health coverage*), dan mengakhiri kematian anak dan ibu yang dapat dicegah. Para ahli juga merekomendasikan agar pengeluaran untuk CBPHC dipantau terutama untuk fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit, yang mencerminkan pentingnya CBPHC untuk mencegah kematian. Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus mengembangkan sistem kesehatan yang menghormati dan menghargai masyarakat sebagai mitra penuh dan bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun dan memperkuat program CBPHC melalui keterlibatan dalam perencanaan, implementasi (termasuk penggunaan tenaga kesehatan di tingkat masyarakat), dan evaluasi. Program CBPHC perlu menjangkau setiap komunitas dan rumah tangga untuk mencapai cakupan universal dari intervensi berbasis bukti utama yang dapat dilaksanakan di masyarakat di luar fasilitas kesehatan dan memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan dapat dijangkau (Black et al., 2017).

Manfaat pendekatan berbasis komunitas:

1. Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan

Program kesehatan berbasis komunitas (*Community-Based Primary Health Care/CBPHC*) dapat memperluas cakupan layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga, meningkatkan akses terhadap perawatan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, dan imunisasi anak. Kontribusi yang dapat diberikan oleh layanan kesehatan primer berbasis masyarakat (CBPHC) dan melibatkan masyarakat sebagai mitra kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak belum banyak dianggap sebagai suatu langkah yang efektif. Kenyataan yang tidak menguntungkan ini adalah salah satu alasan mengapa hanya sedikit negara bisa mencapai Tujuan Pembangunan Milenium terkait kesehatan pada tahun 2015. Para ahli merekomendasikan bahwa CBPHC harus menjadi prioritas untuk memperkuat sistem kesehatan, mempercepat kemajuan dalam mencapai cakupan kesehatan universal dan mengakhiri kematian anak dan ibu yang dapat dicegah. CBPHC didefinisikan sebagai proses di mana sistem kesehatan bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan melalui kegiatan yang mungkin terkait dengan fasilitas kesehatan tetapi berlangsung di masyarakat. Peran masyarakat dan pendekatan berbasis masyarakat dalam meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih dibayangi oleh pendekatan tradisional yang

berpusat pada fasilitas kesehatan dan membutuhkan paradigma baru dimana masyarakat dan layanan berbasis masyarakat dibawa ke dalam arus utama program kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan (Black et al., 2017).

Bukti bahwa intervensi berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (*Maternal, Neonatal and Child Health/MNCH*) terus berkembang selama beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, perawatan kesehatan primer berbasis masyarakat (CBPHC) sebagai pendekatan untuk melibatkan masyarakat dan memberikan intervensi kesehatan kepada masyarakat dan bahkan sampai ke setiap rumah tangga masih menjadi komponen sistem kesehatan yang kurang berkembang. Pemerintah memiliki tanggung jawab atas kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan penyediaan langkah-langkah kesehatan dan sosial yang memadai. Target sosial utama dari pemerintah, organisasi internasional dan seluruh masyarakat dunia dalam beberapa dekade mendatang adalah pencapaian kesehatan untuk semua orang di dunia, tingkat kesehatan yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan primer adalah kunci untuk mencapai target ini sebagai bagian dari pembangunan dalam semangat keadilan sosial (Perry, Rassekh, Gupta, Wilhelm, et al., 2017).

2. Pengurangan Mortalitas

Intervensi berbasis komunitas telah memberikan penurunan yang signifikan dalam mortalitas ibu dan anak, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Pendekatan berbasis komunitas tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut mensukseskan program terutama terkait kesehatan ibu dan anak diantaranya pendidikan kesehatan berbasis kelompok yang dipimpin oleh sukarelawan kesehatan masyarakat (*community health volunteer/CHV*) untuk ibu hamil dan ibu nifas maupun ibu yang memiliki anak balita. Hasil riset menunjukkan bahwa persalinan di fasilitas kesehatan meningkat pada kelompok intervensi, cakupan kunjungan 48 jam pasca persalinan yang lebih tinggi, peningkatan pemberian ASI eksklusif, peningkatan penggunaan kontrasepsi dan peningkatan cakupan kelengkapan imunisasi bayi. Kesimpulannya dengan partisipasi dari CHV dan masyarakat dikaitkan dengan hasil kesehatan ibu dan anak (KIA) yang lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan standar perawatan (Maldonado et al., 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Perry, Rassekh, Gupta, & Freeman (2017) menemukan bahwa dari beberapa proyek komunitas yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun, semuanya telah memeberikan penurunan angka kematian bayi, angka kematian anak usia 1 hingga 4 tahun, atau angka kematian anak di bawah 5 tahun selama setidaknya 10 tahun. Proyek-proyek tersebut memiliki sejumlah karakteristik yang sama. Di antara karakteristik yang paling

menonjol adalah program tersebut menyediakan layanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana yang komprehensif, memiliki program berbasis masyarakat yang kuat yang memanfaatkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melakukan kontak secara teratur dengan semua masyarakat pada level rumah tangga, mengembangkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat yang dilayani, dan memiliki kemampuan rujukan yang kuat serta menyediakan layanan rumah sakit tingkat pertama. Kesimpulannya, dari proyek-proyek ini memberikan panduan tentang bagaimana sistem kesehatan di seluruh dunia dapat meningkatkan efektivitasnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak. Memperkuat komponen-komponen ini akan berkontribusi untuk mencapai tujuan mengakhiri kematian anak dan ibu yang dapat dicegah pada tahun 2030 (Perry, Rassekh, Gupta, & Freeman, 2017).

Kematian ibu sebagian besar terjadi di wilayah Afrika Sub-Sahara, dimana angka kematian ibu dua kali lipat lebih tinggi dari angka kematian ibu dengan ekonomi yang memadai, dan lebih tinggi di antara penduduk pedesaan dan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Anak-anak yang tinggal di negara berpenghasilan rendah memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia lima tahun dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di negara berpenghasilan tinggi. Pneumonia, diare, malaria, dan nutrisi yang tidak memadai menjadi penyebab utama kematian anak usia dini di seluruh dunia. Kekurangan gizi merupakan penyebab utama dari 3,5 juta kematian ibu dan anak setiap tahunnya, stunting, wasting, dan kekurangan gizi mikro bertanggung jawab terhadap sekitar 35 persen beban penyakit pada anak di bawah usia lima tahun dan 11 persen beban penyakit global. Meskipun kematian ibu terutama disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan, preeklamsia, eklamsia, dan sepsis, sebagian besar kematian ibu dapat dikaitkan dengan terbatasnya akses terhadap perawatan terampil selama persalinan dan periode pasca persalinan serta terbatasnya akses terhadap layanan keluarga berencana dan aborsi yang aman. Perpaduan intervensi yang tepat dapat secara signifikan mengurangi beban kesakitan dan kematian pada ibu dan anak (Lassi, 2016).

Perawatan kesehatan yang disediakan di masyarakat, bukan di fasilitas kesehatan, sering kali disediakan oleh *community health workers* (CHW) dan dapat termasuk kunjungan rumah dan paket intervensi lainnya. CHW didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "setiap petugas kesehatan yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pemberian layanan kesehatan dan dilatih dengan cara tertentu dalam konteks intervensi, tetapi tidak menerima pendidikan formal profesional atau paraprofesional atau pendidikan tinggi." CHW haruslah anggota dari, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada

masyarakat tempat mereka bekerja (Hodin S, 2017). Tingkat pelatihan yang diterima CHW, apakah mereka dipekerjakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah dan apakah mereka dibayar atau sukarela, sangat bervariasi antar negara. Secara umum, mereka bekerja bersama dengan petugas kesehatan di garis depan di seluruh layanan kesehatan primer untuk menyediakan pendidikan dan promosi kesehatan, mendistribusikan layanan kesehatan, mendiagnosis dan menangani penyakit, serta memberikan rujukan. Bukti-bukti substansial menunjukkan bahwa intervensi berbasis masyarakat merupakan platform penting untuk meningkatkan layanan dan hasil kesehatan (Lassi, 2016).

3. Pemberdayaan Komunitas

Melibatkan komunitas dalam program kesehatan meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap kesehatan mereka sendiri, yang dapat meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program. Pendekatan partisipatif masyarakat penting untuk intervensi kesehatan ibu dan anak yang efektif. Intervensi partisipatif masyarakat meningkatkan pemanfaatan layanan keluarga berencana, layanan antenatal dan persalinan di fasilitas kesehatan (Mochache et al., 2018).

C. Peran Bidan dalam Pendekatan Berbasis Komunitas

Bidan komunitas adalah seorang tokoh di masyarakat yang membantu ibu selama kehamilan dan persalinan. Dalam masyarakat, bidan memainkan peran positif, mempromosikan sistem perawatan kesehatan untuk ibu dan anak, dan membawa perubahan yang lebih baik terutama untuk kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Bidan komunitas memiliki peran dalam kesehatan ibu dan kesehatan masyarakat. Dalam semua proses tersebut, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan antara ibu dan petugas kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan kesehatan bayi. Peran bidan juga termasuk bekerja secara mandiri untuk mempromosikan kelahiran normal, mengidentifikasi kondisi patologis, melakukan proses darurat ketika diperlukan, memberikan konseling dan pendidikan untuk wanita dan keluarganya selama kehamilan dan persalinan, dan mempromosikan kesehatan di masyarakat yang lebih luas. Bidan dan kesehatan ibu memiliki hubungan yang kuat dan positif. Bidan komunitas dihargai oleh masyarakat karena sangat responsif, dengan dorongan dan dukungan, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien (Tabbassam HF, 2015).

Bidan memegang peran sentral dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi di tingkat komunitas. Mereka tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis, tetapi juga sebagai

pendidik, konselor, dan agen perubahan dalam masyarakat. Adapun peran dan fungsi bidan di komunitas sebagai berikut:

1. Pendidikan Kesehatan

Bidan berperan sebagai pendidik kesehatan bagi masyarakat, khususnya wanita hamil, ibu menyusui, dan keluarga. Mereka memberikan informasi tentang perawatan kehamilan, persalinan yang aman, perawatan pasca persalinan, dan perawatan bayi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan pencegahan komplikasi. Bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka (Varney, 2020)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Bidan memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup *antenatal care* (ANC), persalinan yang aman, *postnatal care* (PNC), serta pelayanan kesehatan bayi dan balita. Mereka memantau perkembangan kehamilan, memberikan imunisasi, dan mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. Bidan adalah ujung tombak dalam mengurangi angka kematian ibu dan bayi melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas (World Health Organization, 2016).

3. Konseling dan Dukungan Emosional

Bidan juga berperan sebagai konselor yang memberikan dukungan emosional kepada wanita hamil dan keluarga mereka. Mereka membantu calon ibu menghadapi kecemasan dan ketakutan selama kehamilan dan persalinan. Dukungan ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman persalinan yang positif. Dukungan emosional yang diberikan oleh bidan dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi risiko depresi pasca persalinan (Leap, 2016).

4. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi

Bidan terlatih untuk mengenali tanda-tanda komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, preeklampsia, atau infeksi. Bidan memberikan penanganan awal sebelum merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kemampuan bidan dalam mendeteksi dan menangani komplikasi secara dini dapat menyelamatkan nyawa (*International Confederation of Midwives, 2014*).

5. Promosi Kesehatan Reproduksi

Bidan mempromosikan kesehatan reproduksi melalui program keluarga berencana, pencegahan infeksi menular seksual (IMS), dan pendidikan tentang kesehatan seksual. Mereka membantu pasangan merencanakan kehamilan yang sehat dan memberikan informasi tentang metode kontrasepsi yang aman. Bidan berperan penting dalam menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan dan

meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

6. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lainnya

Bidan bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Kolaborasi ini memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang holistik dan terintegrasi. Kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah kunci untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal (Varney, 2020).

7. Pemberdayaan Masyarakat

Bidan juga berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program kesehatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mereka mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi efektif untuk meningkatkan kesehatan secara berkelanjutan (World Health Organization, 2016).

D. Strategi Implementasi Pendekatan Berbasis Komunitas

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikontribusikan oleh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas intervensi dan yang dapat memberdayakan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan kepemimpinan lokal dalam memobilisasi masyarakat untuk perencanaan dan pengelolaan kegiatan (termasuk pengelolaan sumber daya eksternal)
2. Memperjelas sistem nilai lokal untuk membantu sistem pelayanan dan masyarakat mengembangkan rasa saling pengertian dan saling menghormati ketika bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang efektif dan adil
3. Melibatkan kelompok perempuan dalam pembelajaran dan aksi partisipatif, pendidikan antar teman, dan penyediaan perawatan berbasis rumah
4. Melibatkan laki-laki dan ibu mertua dengan cara-cara kreatif yang mendorong perilaku sehat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tepat
5. Berpartisipasi dalam mengadaptasi sistem persalinan dengan realitas lokal dan budaya setempat dengan mengintegrasikan intervensi agar dapat diterima dan efisien
6. Berpartisipasi dalam pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas; dan,
7. Berkolaborasi tidak hanya dalam serangkaian intervensi selama tahap awal implementasi, tetapi juga membangun kemitraan jangka panjang untuk sistem yang kuat dan berkelanjutan (Black et al., 2017)

Implementasi lain yang dapat dilakukan agar program kesehatan dapat tercapai adalah melibatkan komunitas dalam desain dan evaluasi program, serta menggunakan petugas/pekerja kesehatan komunitas (*community health workers*) untuk memberikan layanan. Strategi untuk implementasi program semuanya membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dan sistem kesehatan, yang meliputi: (a) desain dan evaluasi program, (b) kolaborasi dengan masyarakat, (c) pendidikan untuk staf di tingkat masyarakat, sukarelawan, penerima manfaat, dan anggota masyarakat, (d) penguatan sistem kesehatan, (e) penggunaan tenaga kesehatan di tingkat masyarakat, dan (f) pelaksanaan intervensi. Empat strategi khusus untuk pelaksanaan intervensi telah diidentifikasi: (a) pengenalan, rujukan, dan (jika memungkinkan) pengobatan penyakit serius pada anak oleh ibu dan/atau agen masyarakat terlatih, (b) kunjungan rutin ke semua rumah, (c) kelompok partisipatif ibu yang dipimpin oleh fasilitator, dan (d) penyediaan layanan kesehatan di lokasi oleh tim kesehatan keliling. Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan titik awal yang berguna untuk desain program dalam memperkuat efektivitas CBPHC untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Perry, Sacks, Schleiff, Kumapley, et al., 2017).

Tabel 2.1: Intervensi Yang Efektif Untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Yang Dapat Diberikan Oleh Petugas Kesehatan Masyarakat (PKM/CHW) Di Masyarakat Atau Di Pos Kesehatan

POINT IN CONTINUUM OF CARE				
Pregnancy	Delivery (normal)	Postpartum (woman)	Postpartum (newborn)	Child
Preparation for safe birth and newborn care; emergency planning	Management of labor and delivery and referral of complications	Promotion of breastfeeding	Neonatal resuscitation	Promote breastfeeding and complementary feeding
Micronutrient supplementation*			Breastfeeding	Provide vitamin A, zinc, and food supplementation
Nutrition education			Thermal care for preterm newborns	Immunizations
Intermittent preventive treatment of malaria during pregnancy)			Promote care-seeking	Co-trimoxazole for HIV-positive children
Food supplementation			Assess for danger signs and refer	Education on safe disposal of children's stools and handwashing
Promotion of HIV testing			Oral antibiotics for pneumonia	Distribute and promote use of ITNs† or IRS‡, or both
				Assess for danger signs and refer
				Detect and refer children with severe acute malnutrition
				Detect and treat serious infections without danger signs (iCCM§), refer if danger signs present

*Because of some evidence of risk and gaps in the evidence, the WHO does not at this time recommend multiple micronutrient supplementation for pregnant women to improve maternal and perinatal outcomes [24].

†Insecticide-treated bednet.

‡Indoor residual spraying.

§Integrated community case management (the components include treatments for diarrhea, pneumonia, malaria).

Source: (Black et al., 2017)

E. Studi Kasus: Keberhasilan Program Berbasis Komunitas di Dunia

Pendekatan inovatif untuk meningkatkan pendekatan CBPHC yang dapat meningkatkan KIA sangat diperlukan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kader petugas kesehatan di tingkat masyarakat yang diberi wewenang oleh pemerintah dengan penambahan tanggung jawab secara bertahap, seperti yang terjadi di Afghanistan, Brasil, Bangladesh, Ethiopia, India, Malawi, Nepal, Niger, Rwanda, dan banyak negara lainnya;
2. Perluasan paket intervensi secara bertahap ke tingkat nasional yang dimulai dengan program kecil yang efektif yang dilaksanakan oleh satu LSM, direplikasi oleh LSM lain, dengan transfer intervensi secara bertahap ke dalam sistem pemerintah seperti yang saat ini sedang berlangsung di India, seperti yang terjadi untuk perawatan neonatal berbasis rumah perawatan neonatal berbasis rumah, dimulai dengan karya perintis SEARCH di Gadchiroli;
3. *Scaling down to scale up*, dimana pendekatan yang berhasil dilakukan direplikasi di lokasi lain dengan masukan dan fleksibilitas lokal yang kuat, seperti yang telah dilakukan oleh *Navrongo Initiative* yang bekerja melalui Kementerian Kesehatan di Ghana;
4. Kemitraan tiga arah, dimana masyarakat, pejabat pemerintah, dan agen dari luar (seperti LSM atau kelompok pendukung teknis) pertama-tama menetapkan lokasi program percontohan sebagai simpul untuk mengadaptasi dan mensistematisasi perluasan ke populasi yang lebih besar, seperti yang dilakukan di Cina dengan Model *Counties Project* (yang sekarang telah menjadi sistem KIA pedesaan Cina) dan seperti yang telah dilakukan oleh *Future Generations* dengan pendekatan SEED-SCALE untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di Arunachal Pradesh (India); Tibet (Cina), Afganistan, dan Peru;
5. Pendekatan pendidikan "*bottom-up*" untuk meningkatkan skala, dimana pekerja dari berbagai wilayah dan program di berbagai negara datang ke pusat pelatihan untuk belajar pemberdayaan dan CBPHC, seperti yang terjadi di Program Kesehatan Pedesaan Komprehensif (CRHP) di Jamkhed, India, di mana lebih dari 30000 orang dari seluruh India dan lebih dari 3000 orang dari 100 negara lain telah dilatih;
6. Penciptaan kerangka kerja nasional yang memberikan pilihan kepada komunitas lokal untuk membangun kontrol bersama atas pusat-pusat kesehatan dan program-program lokal, seperti yang terjadi dalam program *Comunidades Locales para la Administracion de Salud* (CLAS), di mana sepertiga dari 2400 pusat kesehatan pemerintah sekarang dikelola oleh pemerintah; dan,

7. Perluasan secara bertahap dari satu intervensi kunci ke tingkat nasional di bawah arahan satu LSM, seperti yang dilakukan oleh BRAC melalui pelatihan berbasis rumah bagi para ibu untuk mencegah dan mengobati diare. (Black et al., 2017)

Bukti tentang efektivitas CBPHC dalam meningkatkan KIA dalam skala besar masih terbatas. Namun, contoh nasional yang menggembirakan tentang peningkatan KIA ada di negara-negara seperti Afganistan, Brasil, Ethiopia, Nepal dan Rwanda dan negara-negara ini telah membentuk program CBPHC yang kuat yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian ini. Kelompok pendidikan kesehatan perempuan berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak; namun, bukti dari sub-Sahara Afrika masih kurang. *Chamas for Change* (Chamas) adalah program pendidikan kesehatan berbasis kelompok yang dipimpin oleh sukarelawan kesehatan masyarakat (*community health volunteer/CHV*) untuk ibu hamil dan ibu nifas di Kenya bagian barat. Hasilnya ada peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan, capaian yang lebih tinggi dalam kunjungan 48 jam pasca persalinan, pemberian ASI eksklusif yang lebih tinggi, penggunaan kontrasepsi dan kelengkapan imunisasi bayi yang lebih tinggi. Kesimpulannya partisipasi Chamas dikaitkan dengan hasil KIA yang lebih baik secara signifikan. Hasil ini memberikan data yang kuat dari sub-Sahara Afrika untuk mendukung kelompok pendidikan kesehatan perempuan berbasis masyarakat untuk MNCH di tempat yang memiliki sumber daya terbatas. (Maldonado et al., 2020) Penggunaan Teknologi seperti sistem mHealth untuk mendukung pekerja kesehatan komunitas dalam memberikan layanan kesehatan. Program kunjungan rumah yang komprehensif yang dilakukan oleh petugas kesehatan masyarakat (PKM) dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan pengasuh dan meningkatkan kesehatan kesehatan anak dan kesejahteraan ibu di daerah dengan sumber daya yang terbatas, tetapi efektivitas pendekatan ini tidak diketahui di daerah pedesaan di Cina. Selain itu, orang terdekat di keluarga seperti nenek juga memainkan peran penting penting dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan keluarga di daerah pedesaan di Cina, menunjukkan pentingnya melibatkan banyak pengasuh dalam intervensi. Peningkatan kesehatan anak dan kesejahteraan ibu dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum berbasis tahapan yang disampaikan oleh CHW kepada para ibu dan pengasuh anak kecil melalui kunjungan rumah dengan bantuan sistem mHealth berbasis tablet (Chen et al., 2023).

Tabel 2.2: Rekomendasi Panel Ahli untuk Mendorong Pemberdayaan Komunitas dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak

Rekomendasi Utama	Detail
Memberdayakan komunitas dan perempuan dalam komunitas tersebut agar lebih aktif terlibat dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak-anak	• Membangun dasar nilai yang mendukung kemitraan dengan komunitas serta proses untuk meningkatkan kapasitas komunitas melalui pemberian suara dalam pengawasan atau pengendalian aspek tertentu dari layanan kesehatan pemerintah lokal. • Meningkatkan peran perempuan, seperti melalui program pemberdayaan perempuan, dukungan program kredit mikro, dan pengembangan program bantuan tunai bersyarat. • Mendukung pengembangan organisasi berbasis komunitas yang berfokus pada kebutuhan kesehatan lokal serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan setempat.
Membangun kemitraan yang lebih kuat antara komunitas dan sistem kesehatan	• Menciptakan budaya sistem kesehatan yang menghormati dan bekerja sama dengan anggota komunitas. • Membangun alur komunikasi dua arah. • Membentuk keterkaitan dua arah antara sistem kesehatan tingkat distrik dan komunitas untuk membantu semua pihak bertanggung jawab terhadap kinerja sistem kesehatan.
Melibatkan komunitas dalam pemantauan, evaluasi, dan penggunaan informasi terkait kesehatan	• Membuat sistem untuk pengumpulan dan pemanfaatan data kesehatan oleh komunitas, termasuk pencatatan kelahiran dan kematian, serta identifikasi individu yang paling membutuhkan layanan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan dalam semua tahap pelayanan kesehatan. • Mengembangkan pendekatan partisipatif dalam pemantauan dan

	evaluasi program CBPHC, termasuk penilaian dampak kematian.
--	---

Source: (Black et al., 2017)

F. Tantangan dan Solusi dalam Pendekatan Berbasis Komunitas

Belum ada kemajuan yang signifikan di negara berpenghasilan rendah dan menengah (*Low Middle Income Country/LMIC*) untuk mengurangi angka kematian ibu hingga tiga perempat dan kematian balita hingga dua pertiga, yang merupakan target dari Tujuan Pembangunan Milenium 5 dan 4. Pada tahun 2010 saja, 287 ribu ibu dan 7,6 juta balita meninggal akibat komplikasi kehamilan dan kurangnya perawatan kesehatan yang memadai. Meskipun intervensi berbasis bukti yang efektif berdasarkan biaya yang diperkirakan dapat mencegah hingga sepertiga dari komplikasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan kematian dengan cakupan universal telah diidentifikasi, namun lebih dari 50% anak-anak di daerah yang kekurangan sumber daya tidak memiliki akses ke intervensi sederhana ini. Sembilan puluh sembilan persen kematian ibu dan anak terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana terdapat kekurangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang parah, yang merupakan salah satu kendala paling signifikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) 4 dan 5. Petugas Kesehatan Masyarakat/*community health workers* (PKM) bertindak sebagai faktor penanggulangan krisis KIA dengan menyediakan perawatan KIA yang penting di tingkat rumah tangga dan masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan dalam perawatan kesehatan untuk populasi yang terpinggirkan, memberikan pendidikan dan layanan kesehatan terutama kuratif, dan memiliki peran penting dalam menjadi penghubung antara masyarakat dengan tenaga yang lebih terampil dan layanan berbasis fasilitas (Gilmore & McAuliffe, 2013).

Setiap wanita layak mendapatkan perhatian, perhatian budaya, serta perawatan yang terfokus pada bagaimana dan dengan siapa mereka ingin menerima perawatan kesehatan ibu. Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu yang sesuai dan dimanapun mereka berada. Sayangnya, masih banyak sistem kesehatan yang belum memiliki kapasitas ataupun infrastruktur dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu (dengan standar tinggi) pada level komunitas. Dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan ibu berbasis komunitas, dibutuhkan tenaga kesehatan yang kuat dan terlatih, serta adanya sistem rujukan dan transportasi yang efisien, juga infrastruktur yang jelas. Sebuah tinjauan sistematis 2013 menyimpulkan bahwa CHWs (program berbasis komunitas) dapat secara efektif menyampaikan pesan pendidikan, meningkatkan akseptabilitas praktik perawatan bayi baru lahir

seperti kontak kulit ke kulit dan menyusui eksklusif dan memberikan intervensi termasuk pengobatan pencegahan intermiten untuk layanan malaria dan psikososial. Namun, penelitian tambahan mengenai berbagai jenis program CHW dalam beragam pengaturan diperlukan untuk mengidentifikasi model paling sukses untuk peningkatan skala (FKKMK UGM, 2018).

Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan para sukarelawan dan komunitas dapat dilibatkan dalam pendidikan dan promosi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas dengan pengetahuan dan keahlian yang memadai. Salah satu cara yang digunakan untuk memberdayakan komunitas dengan mengorganisir kelompok perempuan yang fokus terhadap beberapa isu kesehatan tertentu. Dalam suatu penelitian di India menyebutkan bahwa dengan adanya intervensi dari komunitas, angka kematian anak bisa menurun hingga 30%. Penurunan angka kematian anak didukung dengan meningkatnya inisiasi menyusui dini (IMD) dan penyuluhan terkait perilaku hidup sehat dari komunitas-komunitas. Pada suatu review sistematis pada 2013, disebutkan bahwa peran komunitas wanita dalam KIA cukup berpengaruh dalam menurunkan angka kematian ibu. Peran yang dapat dilakukan oleh komunitas perempuan antara lain dalam melakukan identifikasi dan deteksi dini terkait adanya masalah dalam kehamilan hingga persalinan. Hal ini dapat menurunkan AKI sebesar 23% dan angka kematian anak sebesar 20% (FKKMK UGM, 2018).

Permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur meliputi tingginya WUS usia remaja, rendahnya Pada negara-negara dengan SDM terlatih yang rendah, akan lebih sulit dalam mencapai tujuan untuk menurunkan AKI. Namun tidak ada aturan atau standar tertentu dalam suatu komunitas untuk meningkatkan perannya dalam penurunan AKI. Hal yang diatur oleh WHO sendiri lebih cenderung pada SOP dalam intervensi terkait proses persalinan ibu, antara lain penggunaan oxytocin sebagai uterotonic untuk mencegah perdarahan. Dalam suatu review sistematis disebutkan bahwa dalam suatu komunitas, penggunaan misoprostol selama home visit lebih besar dibandingkan saat ANC. Dalam upaya meningkatkan kualitas dari komunitas dibutuhkan pelatihan dan supervisi untuk memastikan komunitas memberikan pelayanan yang berkualitas utamanya terkait KIA. Metode pelatihan yang sering digunakan adalah sesi kelas interaktif, diskusi dengan grup-grup kecil, dan pelatihan lapangan/ praktik langsung. Dalam pelatihan ini harus diperhatikan dan diterapkan sesuai dengan keragaman yang ada di lingkungan tersebut seperti budaya dan kepercayaan. Melalui komunitas ini, pemerintah dapat lebih mudah dalam mensosialisasikan program-program baru terkait KIA. Selain itu juga adanya teknologi baru yang berhubungan dengan KIA akan dikenalkan ke masyarakat melalui keberadaan komunitas (FKKMK UGM, 2018).

Tabel 2.3: Rekomendasi Panel Ahli Untuk Memperkuat Sistem Persalinan Demi Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak

Rekomendasi	Detail
Perluas sistem layanan ke setiap komunitas dan rumah tangga	• Libatkan anggota komunitas dalam pemberian layanan. • Latih dan dukung pekerja komunitas yang (1) menerima insentif atau gaji yang cukup untuk keterlibatan jangka panjang, (2) menerima supervisi teknis dan dukungan dari staf di fasilitas kesehatan terdekat, dan (3) bertanggung jawab kepada komunitas lokal mereka. • Berikan pelatihan dan supervisi yang sesuai kepada pekerja komunitas (yang sebaiknya dipilih dari dan oleh komunitas tempat mereka bekerja) agar dapat melakukan tugas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan prioritas epidemiologi ibu serta anak. • Latih dan dukung relawan lingkungan untuk promosi kesehatan secara peer-to-peer. • Kembangkan keseimbangan yang tepat antara pekerja komunitas untuk intensitas layanan yang dibutuhkan, sambil memastikan beban kerja yang sesuai dan cukup waktu untuk setiap tugas. • Koordinasikan aktivitas sektor kesehatan formal dengan sektor informal (penjual obat dan praktisi individu, termasuk dukun).
Promosikan pemberian intervensi bagi mereka yang paling berisiko	• Sediakan "jaring pengaman" yang mengurangi hambatan dalam akses dan pemberian layanan (misalnya, sistem asuransi yang ramah CBPHC untuk memberikan remunerasi kepada penyedia layanan dan skema insentif guna mendorong pemanfaatan layanan kesehatan). • Ciptakan strategi pelayanan yang adil untuk mengidentifikasi dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Bangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih kuat, lebih efisien, dan lebih efektif	• Sediakan pendanaan global, nasional, dan lokal yang memadai, berkelanjutan, serta fleksibel untuk program berbasis komunitas sesuai dengan jumlah anggaran yang digunakan untuk layanan berbasis fasilitas. • Dorong investasi di tingkat komunitas dan lokal untuk mendukung program berbasis komunitas serta memperkuat pelayanan kesehatan primer di fasilitas kesehatan perifer. • Sediakan pasokan yang memadai untuk pemberian layanan. • Integrasikan layanan di tingkat komunitas (berdasarkan kapasitas sistem pelayanan dan kebutuhan lokal). • Pantau pengeluaran untuk CBPHC dibandingkan dengan pusat kesehatan primer dan rumah sakit, serta pastikan bahwa tingkat ini sesuai dengan pentingnya CBPHC dalam mencegah kematian.
---	---

Source: (Black et al., 2017)

G. Kesimpulan

Pendekatan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan formal. Model ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif, serta kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader kesehatan, pemimpin komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya, pendekatan ini melibatkan berbagai intervensi berbasis komunitas, seperti kelas ibu hamil, posyandu, program kunjungan rumah (*home visit*), dan pendampingan ibu pascapersalinan. Peran bidan sebagai fasilitator, edukator, dan advokat kesehatan menjadi sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat di tingkat komunitas. Dengan demikian, bidan tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Meskipun pendekatan ini memiliki banyak manfaat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan kebijakan, resistensi budaya, serta rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dan kader, advokasi kebijakan untuk mendukung intervensi berbasis komunitas, serta strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan pendekatan berbasis komunitas tidak hanya berdampak pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih mandiri dan tangguh dalam mengelola kesehatannya sendiri. Dengan adanya sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, diharapkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi dapat terus menurun, sehingga tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dapat tercapai.

H. Referensi

-
- Black, R. E., Taylor, C. E., Arole, S., Bang, A., Bhutta, Z. A., Chowdhury, A. M. R., Kirkwood, B. R., Kureshy, N., Lanata, C. F., Phillips, J. F., Taylor, M., Victora, C. G., Zhu, Z., & Perry, H. B. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 8. summary and recommendations of the expert panel. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010908>
- Chen, Y., Wu, Y., Dill, S. E., Guo, Y., Westgard, C. M., Medina, A., Weber, A. M., Darmstadt, G. L., Zhou, H., Rozelle, S., & Sylvia, S. (2023). Effect of the mHealth-supported Healthy Future programme delivered by community health workers on maternal and child health in rural China: Study protocol for a cluster randomised controlled trial. *BMJ Open*, 13(1). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-065403>
- FKMK UGM. (2018). Progam Intervensi Komunitas Dalam Kesehatan Ibu Dan Anak. <https://Kanalpengetahuan.Fk.Ugm.Ac.Id/Progam-Intervensi-Komunitas-Dalam-Kesehatan-Ibu-Dan-Anak/>.
- Gilmore, B., & McAuliffe, E. (2013). Effectiveness of community health workers delivering preventive interventions for maternal and child health in low- and middle-income countries: a systematic review. *BMC Public Health*, 13(1), 847. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-847>
- International Confederation of Midwives. (2014). The Role of the Midwife in the Community. <https://www.internationalmidwives.org>.
- Jennings, M. C., Pradhan, S., Schleiff, M., Sacks, E., Freeman, P. A., Gupta, S., Rassekh, B. M., & Perry, H. B. (2017). A comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving

- maternal, neonatal and child health: 2. maternal health findings. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010902>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peran dan Fungsi Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. [Http://Www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id).
- Lassi, Z. , K. R. , & B. Z. (2016). Community-Based Care to Improve Maternal, Newborn, and Child Health. In *Community-Based Care to Improve Maternal, Newborn, and Child Health*.
- Leap, N. , & H. B. (2016). *Supporting Women for Labour and Birth: A Thoughtful Guide*. Routledge.
- Maldonado, L. Y., Bone, J., Scanlon, M. L., Anusu, G., Chelagat, S., Jumah, A., Ikemeri, J. E., Songok, J. J., Christoffersen-Deb, A., & Ruhl, L. J. (2020). Improving maternal, newborn and child health outcomes through a community-based women's health education program: A cluster randomised controlled trial in western Kenya. *BMJ Global Health*, 5(12). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003370>
- Mochache, V., Irungu, E., El-Busaidy, H., Temmerman, M., & Gichangi, P. (2018). "Our voices matter": a before-after assessment of the effect of a community-participatory intervention to promote uptake of maternal and child health services in Kwale, Kenya. *BMC Health Services Research*, 18(1), 938. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3739-9>
- Perry, H. B., Rassekh, B. M., Gupta, S., & Freeman, P. A. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 7. shared characteristics of projects with evidence of long-term mortality impact. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010907>
- Perry, H. B., Rassekh, B. M., Gupta, S., Wilhelm, J., & Freeman, P. A. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 1. rationale, methods and database description. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010901>
- Perry, H. B., Sacks, E., Schleiff, M., Kumapley, R., Gupta, S., Rassekh, B. M., & Freeman, P. A. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 6. strategies used by effective projects. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010906>
- Ridlo, I. A., Ridwanah, A. A., Yoto, M., & Laksono, A. D. (n.d.). *Intervensi Berbasis Komunitas: Sebuah Pengantar*.
- Sarah Hodin. (2017, March 20). *Community-Based Maternal Health Care: Meeting*

- Women Where They Are. <https://www.mhtf.org/2017/03/20/Community-Based-Maternal-Health-Care-Meeting-Women-Where-They-Are/>.
- Tabbassam HF, M. R. (2015). A Co-relational Study of Community Midwife and Maternal Health Care System: A Questionnaire Survey in Rural Areas of Pakistan. *Iran J Public Health*, 44(1), 140–141.
- Varney, H. , K. J. M. , & G. C. L. (2020). *Varney's Midwifery*. Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2016). *Midwifery Education and Care: Strengthening Quality Midwifery Care for Women and Newborns*. <https://www.who.int>.

CHAPTER 3

STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN IBU HAMIL

Dr. Cut Sriyanti, SST, M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development* (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru untuk membawa perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan guna menggerakkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diterapkan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang akan terlewatkan (*No-one Left Behind*). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya serta pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir pada tahun 2015 yang lalu (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Salah satu tujuan SDGs yang ditetapkan, salahsatunya tujuan ke 3 (tiga) adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan sehat serta meningkatkan kesejahteraan semua penduduk pada setiap tingkatan usia. Adapun target dari 3.1 yaitu mengurangi kematian ibu dengan target di tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu sampai dengan kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia termasuk nomor tiga paling tinggi di negara Asia Tenggara, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI, dalam kegiatan temu wicara pada akhir Desember 2023. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah berat badan lahir rendah (BBLR), sedangkan penyebab kematian terbanyak pada ibu yaitu pendarahan dan eklampsia (tekanan darah tinggi) dan kejang yang terjadi pada masa kehamilan atau persalinan (Kemenkes, 2018).

Inilah mengapa penting melakukan pemeriksaan kehamilan di Layanan Kesehatan secara rutin oleh tenaga kesehatan terlatih, sebagai salah satu Upaya dan solusi efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu juga, sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran ibu terhadap pemeriksaan kehamilan di layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. (Kemenkes, 2018)

Kehamilan merupakan masa yang fundamental dan perubahan yang terjadi pada tahap ini memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi yang baru dilahirkan, serta di masa yang akan datang. Oleh karena itu, asuhan berkualitas dalam masa kehamilan sangat penting bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin yang dikandungnya. Asuhan yang tidak memadai selama masa kehamilan akan mengganggu proses dalam rangkaian perawatan, dan akan berdampak pada ibu dan bayi (UNICEF, 2019).

Pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) yaitu pemeriksaan kehamilan dengan tujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu selama hamil, hingga siap menghadapi masa persalinan, masa nifas, pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya secara alami dan bertahap kesehatan alat reproduksi ibu. Selama masa kehamilan pemeriksaan dilakukan minimal 6 (enam) kali, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga (Kemenkes, 2023).

Adapun tujuan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin adalah untuk memantau masa kehamilan guna memastikan keadaan kesehatan ibu selama proses kehamilan, juga pertumbuhan janin didalam rahim ibu; mendeteksi adanya komplikasi/kelainan atau masalah kehamilan secara dini, termasuk jika adanya riwayat penyakit ibu hamil dan tindakan pembedahan sebelumnya; meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ibu dan bayi yang dikandung; mempersiapkan proses persalinan untuk meminimalkan kemungkinan trauma yang terjadi pada saat proses persalinan, sehingga ibu dapat melahirkan bayi dengan sehat dan selamat; mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu hamil; mempersiapkan peran ibu, ayah dan keluarga dalam menerima kehadiran anak serta memastikan tumbuh kembangnya secara normal; mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas dan memberikan ASI eksklusif pada bayinya dengan tepat dan lancar (Kemenkes, 2018).

Seorang ibu dapat memeriksakan kehamilannya di puskesmas, posyandu, praktik bidan mandiri (PMB), klinik, atau rumah sakit oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan, dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan). Hal-hal yang diperiksa pada ibu hamil meliputi 10 T, yaitu: (Kemenkes, 2023)

1. Timbang Berat Badan dan ukur Tinggi Badan

Pemantauan berat badan ibu selama hamil sesuai grafik peningkatan berat badan bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pada pertumbuhan janin dalam kandungan ibu. Sedangkan pengukuran tinggi badan bertujuan untuk mengetahui adanya faktor risiko yang dapat mempersulit proses persalinan, seperti cephalopelvic Disproporstion (CFD) pada ibu hamil, apabila badan kurang dari 145 cm.



Gambar 3.1: Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan ibu hamil
Sumber : (Kemenkes, 2023)

2. Ukur Tekanan Darah

Pemantauan tekanan darah ibu hamil bertujuan untuk menghindari risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu tekanan darah di atas 140/90 mmHg. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan ibu hamil rentan terkena eklamsia, sehingga membahayakan kehamilan serta persalinan, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian pada ibu.



Gambar 3.2: Pengukuran Tekanan darah ibu hamil
Sumber : (Kemenkes, 2023)

3. Ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Untuk mengetahui status gizi ibu hamil dilakukan pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran ini hanya dilakukan satu kali yaitu pada trimester pertama. Apabila ditemukan hasil LiLA ibu hamil kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil dapat berpotensi mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis) sehingga meningkatkan risiko yaitu bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR.



Gambar 3.3: Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) pada ibu
Sumber : (Kemenkes, 2023)

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri (Tinggi Rahim)

Pengukuran tinggi rahim bertujuan untuk memperkirakan perkembangan janin yang berada didalam kandungan, yaitu dengan mengukur jarak dari puncak tulang panggul sampai pada bagian teratas pada perut ibu hamil. Normalnya tinggi fundus yaitu 2 cm lebih besar dari usia kehamilan ibu. Jikalau usia kehamilan ibu 12 minggu, maka tinggi fundus atau rahim ibu yaitu 10-14 cm.



Gambar 3.4: Pengukuran Tinggi Rahim
Sumber : (Kemenkes, 2023)

5. Tentukan Letak Janin dan Denyut Jantung Janin

Menentukan letak dan denyut jantung janin bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan letak janin atau masalah lain. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada trimester kedua akhir.



Gambar 3.5: Menentukan Letak Janin dan Denyut Jantung Janin
Sumber : (Kemenkes, 2023)

6. Skrining Status Imunisasi Tetanus

Tujuannya untuk mengetahui bagaimana status imunisasi ibu hamil, serta menyuntikkan vaksin tetanus jika ibu belum mendapatkan vaksin, guna menciptakan kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus.



Gambar 3.6: Melakukan Imunisasi Tetanus pada ibu
Sumber : (Kemenkes, 2023)

7. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Tablet Tambah Darah (TTD) mengandung sedikitnya 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat, dan harus diminum ibu hamil setiap hari selama hamil. Konsumsi minimal 90 tablet zat besi, sangat dianjurkan bagi ibu hamil yang bertujuan untuk mencegah kekurangan zat besi dan anemia.



Gambar 3.7 Ibu mengkonsumsi Tablet Tambah Darah
Sumber : (Kemenkes, 2023)

8. Pemeriksaan Laboratorium/Penunjang

Terdiri dari pemeriksaan kadar hemoglobin dan pemeriksaan darah lainnya sesuai indikasi kondisi kesehatan yang ditemui saat pemeriksaan, kadar protein pada urin dan kondisi kehamilan dan janin melalui Ultrasonografi/USG.



Gambar 3.8: Pemeriksaan Laboratorium dan USG pada Ibu Hamil

Sumber : (Kemenkes, 2023)

9. Tata Laksana/Penanganan Kasus

Pada saat pemeriksaan kehamilan, apabila ditemukan masalah atau kelainan dokter atau bidan dapat segera memberikan penanganan atau merujuk pada tenaga ahli lainnya.



Gambar 3.9 Penatalaksanaan kasus pada ibu hamil yang mengalami komplikasi

Sumber : (Kemenkes, 2023)

10. Temu Wicara atau Konseling

Setiap kali kunjungan pemeriksaan kehamilan di puskesmas, ibu dan keluarga dapat melakukan temu wicara atau konseling baik dengan bidan atau dokter yang menangani. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan ibu dan janin dalam kandungan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kehamilan yang sehat dan lancar.



Gambar 3.10: Pemberian Konseling pada ibu dan keluarga

Sumber : (Kemenkes, 2023)

Meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan wanita hamil sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan ibu serta janin. Berbagai strategi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran ini, dengan fokus pada pendidikan, teknologi, keterlibatan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi dan sosial ibu hamil. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan dan mempromosikan praktik sehat selama kehamilan.

B. Pendidikan Prenatal

Pendidikan prenatal adalah proses pemberian informasi yang memiliki dua tujuan, yaitu mengenalkan orang tua yang sedang hamil dengan komponen-komponen utama kehamilan dan persalinan serta mempersiapkan ibu dan/atau pasangannya untuk merawat bayi yang baru lahir. Tingkat pendidikan prenatal di berbagai negara tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan di Australia, tingkat kehadirannya dilaporkan mencapai 84%, sementara di Kanada, diperkirakan sekitar 33%. Pendidikan prenatal biasanya diberikan melalui pengalaman yang dibagikan dengan keluarga atau kerabat, terutama pada populasi berpenghasilan rendah, pedesaan, atau tidak berpendidikan, serta melalui internet atau kelompok media bersama, yang melayani individu yang lebih muda dan lebih bergantung pada media (Gitas et al., 2021)

Penelitian yang dilakukan Nuraida & Putri (2024) membuktikan program pendidikan kesehatan secara efektif meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan meningkatkan praktik kesehatan untuk anak di bawah lima tahun di komunitas Cibinong, menunjukkan bahwa upaya pendidikan yang ditargetkan dapat menyebabkan perubahan positif yang signifikan dalam kesadaran kesehatan ibu dan anak. Program ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan otoritas kesehatan setempat, menerangkan bahwa dukungan berkelanjutan

dan perluasan inisiatif pendidikan kesehatan sangat penting untuk mempertahankan peningkatan kesejahteraan wanita hamil dan balita di tingkat masyarakat.

Hasil penelitian lain mengungkapkan bahwa pendidikan kesehatan secara signifikan meningkatkan pengetahuan wanita hamil tentang kehamilan berisiko tinggi, yang mengarah pada kesadaran yang lebih baik dan manajemen proaktif kesehatan mereka selama kehamilan. Peningkatan pengetahuan ini sangat penting untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan memahami pentingnya pemeriksaan rutin. Temuan menunjukkan bahwa berbagai metode pendidikan, termasuk penggunaan selebaran, buklet, dan media audiovisual, secara efektif meningkatkan pemahaman tentang faktor kehamilan berisiko tinggi di antara wanita hamil. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga berkontribusi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan kehamilan berisiko tinggi, yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan janin (Handayani et al., 2023).

Strategi efektif yang direkomendasikan untuk memperkuat kesadaran perempuan adalah mengatasi hambatan pencarian kesehatan, terutama di tingkat rumah tangga, dengan menilai hambatan ini sebagai bagian dari program ANC. Selain itu, menggunakan alat seperti buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA) atau aplikasi seluler untuk merekam kunjungan ANC dapat membantu meningkatkan komunikasi dengan keluarga dan meningkatkan kesadaran (Yunitasari et al., 2023).

Perlunya mendidik wanita yang merencanakan kehamilan dan wanita hamil tentang efek nutrisi tertentu dan risiko kekurangannya. Strategi untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dapat mencakup lokakarya, sesi informasi, dan distribusi materi pendidikan yang berfokus pada kebiasaan gizi yang tepat. Selain itu, memanfaatkan penyedia layanan kesehatan untuk menyebarkan pengetahuan dan mendorong kelompok pendukung masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan mempromosikan pilihan diet yang lebih sehat di antara wanita hamil, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan ibu dan janin. Hasil penelitian membuktikan 81,8% wanita mengkonfirmasi membuat perubahan dalam diet mereka setelah kehamilan, misalnya lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan (79,6%), menghindari produk olahan tinggi (61,1%), dan menghindari permen (50,0%) (Mandryk & Węgrzyn, 2023).

Program pendidikan prenatal yang komprehensif dirancang untuk mempersiapkan calon orang tua selama masa kehamilan hingga persalinan, yang meliputi:

1. Pemantauan Kesehatan Kehamilan

- a. Pemeriksaan Rutin: Kunjungan rutin dengan dokter kandungan atau bidan untuk memantau kesehatan ibu dan janin merupakan hal yang sangat penting. Kunjungan ini biasanya mencakup penilaian seperti pemeriksaan tekanan darah, pemantauan berat badan, dan pemantauan detak jantung janin (Amin et al., 2024; Da Silva & Rodrigues, 2022).
- b. Skrining dan Tes: Skrining penting termasuk tes darah, ultrasound, dan skrining genetik untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi potensi komplikasi sejak dini (Amin et al., 2024; Da Silva & Rodrigues, 2022).
- c. Pemantauan Pertumbuhan Janin: Ultrasonografi dan pengukuran secara teratur membantu melacak pertumbuhan dan perkembangan janin, memastikan masalah apa pun dapat ditangani dengan cepat (Amin et al., 2024).

2. Pendidikan tentang Nutrisi Sehat dan Gaya Hidup (Amin et al., 2024)

- a. Panduan Diet Seimbang: Pendidikan tentang mempertahankan diet seimbang yang kaya nutrisi penting sangat penting untuk perkembangan janin dan kesehatan ibu.
- b. Suplemen Vitamin dan Mineral: Program sering merekomendasikan suplemen seperti asam folat dan zat besi untuk mencegah kekurangan zat besi.
- c. Aktivitas Fisik Aman: Panduan latihan yang aman membantu menjaga kesehatan fisik dan mempersiapkan tubuh untuk melahirkan.
- d. Penghindaran Zat Berbahaya: Pendidikan tentang menghindari alkohol, rokok, dan zat berbahaya lainnya ditekankan untuk mencegah hasil yang merugikan.

3. Persiapan untuk Melahirkan (Nolan, 2020)

- a. Tanda-tanda Persalinan: Mendidik orang tua hamil tentang mengenali tanda-tanda persalinan memastikan intervensi medis tepat waktu.
- b. Teknik Pernafasan dan Relaksasi: Teknik seperti latihan pernapasan dan metode relaksasi diajarkan untuk mengatasi nyeri persalinan.
- c. Pilihan Metode persalinan: Informasi tentang metode persalinan yang berbeda membantu orang tua membuat keputusan berdasarkan informasi.
- d. Persiapan Rumah Sakit: Panduan tentang dokumentasi yang diperlukan dan prosedur rumah sakit mempersiapkan orang tua untuk proses persalinan.

4. Menyusui Eksklusif

- a. Kontak kulit ke kulit segera setelah lahir sangat penting untuk memulai menyusui dan meningkatkan tingkat eksklusivitas (Bellizzi et al., 2024)].
- b. Model perawatan yang berpusat pada keluarga yang melibatkan kedua orang tua dapat meningkatkan frekuensi menyusui serta penambahan berat badan yang lebih baik pada bayi yang baru lahir (Wanduru et al., 2024).

5. Perawatan Tali Pusar

Sementara ibu umumnya memiliki praktik yang baik dalam perawatan bayi baru lahir, kesadaran akan perawatan tali pusat yang tepat sering kurang (Dangol et al., 2023).

6. Pengenalan Tanda-tanda Bahaya

Mendidik orang tua tentang mengenali tanda bahaya bayi baru lahir sangat penting untuk intervensi dan perawatan yang tepat waktu (Dangol et al., 2023).

7. Dukungan Psikologis dan Manajemen Stres (Wanduru et al., 2024)

- a. Perawatan yang berpusat pada keluarga dapat mengurangi kecemasan dan stres orang tua, mempromosikan hasil kesehatan mental yang lebih baik bagi ibu.
- b. Strategi manajemen stres yang menargetkan ibu sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup bayi baru lahir dan kesejahteraan ibu.

8. Memperkuat Hubungan Pasangan dan Peran Pengasuhan (Bellizzi et al., 2024)

- a. Melibatkan ayah dalam perawatan bayi baru lahir sejak awal memperkuat hubungan pasangan dan mengklarifikasi peran pengasuhan.
- b. Komunikasi yang efektif dan tanggung jawab bersama adalah kunci keberhasilan pengasuhan dan dinamika hubungan.

9. Jaringan Dukungan dan Layanan Kesehatan

- a. Akses ke layanan kesehatan darurat dan konsultasi dengan petugas kesehatan merupakan komponen penting dari perawatan bayi baru lahir yang komprehensif (Gontasz et al., 2024).
- b. Jaringan pendukung, termasuk kelompok ibu hamil dan dukungan keluarga, memberikan bantuan emosional dan praktis yang esensi (Bellizzi et al., 2024).

C. Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan Kesehatan

Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan wanita hamil. Dengan memanfaatkan sensor yang dapat dikenakan, perangkat IoT, dan aplikasi seluler, penyedia layanan kesehatan dapat memfasilitasi pemantauan berkelanjutan dan intervensi tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan ibu dan janin.

Penelitian yang dilakukan oleh Alotaibi et al., (2018) di Arab Saudi mengkonfirmasi bawa aplikasi seluler kehamilan dirancang untuk meningkatkan kesadaran kehamilan dan memfasilitasi pemantauan jarak jauh, memungkinkan wanita hamil di Arab Saudi untuk mempertahankan gaya hidup normal sambil menerima pemantauan intensif dan perawatan yang dioptimalkan di rumah. Sistem

ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dalam membantu wanita hamil untuk menghindari kelainan dan penyakit selama kehamilan. Di dalam aplikasi ini mencakup fitur-fitur seperti fasilitasi komunikasi antara wanita hamil dan penyedia layanan kesehatan, jejaring sosial untuk berbagi pengalaman, dan alat untuk melacak aktivitas fisik dan gerakan bayi.

Teknologi lainnya seperti sensor yang dapat dikenakan oleh ibu dapat memantau tanda-tanda vital seperti EKG, kontraksi uterus, dan gerakan janin, memberikan data real-time kepada pasien dan penyedia layanan Kesehatan. Selain itu integrasi algoritma AI meningkatkan deteksi dini potensi masalah kesehatan, memungkinkan manajemen proaktif dari pemberi layanan kesehatan (Liu et al., 2024).

Sistem pemantauan kesehatan dengan menggunakan *internet of things* (IoT) digunakan untuk memantau parameter kesehatan ibu hamil dan bayi. Perangkat ini akan dapat memonitor elektrokardiogram, tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan tingkat oksigen wanita dan semua data dikirim ke cloud dan pesan ke wanita hamil melalui modul GSM tentang parameter kesehatan mereka dan pesan peringatan kepada dokter jika ada hal yang tidak normal diidentifikasi yang dikirim melalui sistem pemantauan kesehatan jarak jauh (Supraja et al., 2023).

Aplikasi seluler *Risk identification, Evaluation counseling, Systematic monitoring, Troubleshooting* (REST) secara signifikan meningkatkan kunjungan ANC dan mengurangi komplikasi, meningkatkan metode persalinan normal dan berat lahir normal. Aplikasi mobile REST merupakan aplikasi pertama yang dirancang untuk digunakan oleh bidan dan ibu hamil, dimana data yang diinput oleh bidan dan ibu hamil akan terintegrasi satu sama lain. Penggunaan aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai pembaharuan pemantauan kesehatan ibu secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan desain RCT cluster dengan harapan ada kelompok pembandingan yang akan digunakan sebagai pembandingan efektivitas penggunaan aplikasi REST. Aplikasi REST didefinisikan dari Risk Identification, yaitu mengidentifikasi risiko oleh bidan dari hasil pemeriksaan, Evaluation counseling, yaitu adanya konseling berbasis aplikasi, konseling dari bidan kepada ibu hamil sehingga memudahkan ibu hamil untuk mengambil keputusan, Pemantauan sistematis, yaitu pemantauan yang dilakukan bidan secara sistematis dengan terfokus pada 10T, yang meliputi menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan (T1), Mengukur tekanan darah (T2), Mengukur Lingkar Lengan Atas (T3), Mengukur Tinggi Fundus Uteri (T4), Pemberian Imunisasi Tetanus (T5), Pemberian Tablet Tambah Darah (T6), Menentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (T7), Penyuluhan Persiapan Persalinan dan Nifas (T8), Memeriksa Kadar Hemoglobin (T9), Memberikan Asuhan Sesuai Kebutuhan (T10) [3]. Pemecahan masalah yaitu

menentukan solusi masalah oleh bidan kepada ibu hamil dalam kelompoknya (Pangestuti et al., 2024).

Teknologi lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan pada ibu hamil yaitu sistem pemantauan kesehatan kehamilan yang memungkinkan wanita untuk mengakses perawatan berkualitas dari jarak jauh selama kehamilan. Integrasi perangkat yang dapat dikenakan telah memberikan dampak positif pada teknologi pemantauan kesehatan ibu, yang memungkinkan ibu hamil dipantau secara terus menerus. Akibatnya, kebutuhan untuk menilai kegunaannya semakin meningkat. Sebuah sistem pemantauan kehamilan berbasis web yang memanfaatkan perangkat *Internet-of-Things* (IoT) yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar, alat tekanan darah, dan fetal doppler untuk membantu pemantauan tanda vital. Sebuah aplikasi berbasis seluler dikembangkan untuk memungkinkan sinkronisasi informasi tanda vital sebagai bagian dari asuhan perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mudah digunakan, dinavigasi, dan diingat (Samonte et al., 2023).

D. Penguatan Sistem Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Memperkuat sistem dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan wanita hamil. Intervensi yang efektif telah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan ibu dengan menumbuhkan pengetahuan dan mendorong pemeriksaan kesehatan rutin.

Pendidikan kesehatan berbasis masyarakat yang dipimpin oleh kelompok perempuan secara signifikan meningkatkan pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kebidanan dan kesiapan kelahiran dan praktik kesiapan komplikasi di Ethiopia selatan (Yoseph et al., 2023).

Kegiatan lainnya yang berbasis masyarakat yaitu Pelayanan Komprehensif Kesehatan Ibu Hamil yaitu Gerakan Ibu Hamil Sadar Pemeriksaan Kesehatan (GEBUKIN) Tahun 2021-2023, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil sebesar 30%, peningkatan kunjungan dan kesadaran masyarakat (kader dan pendamping ibu hamil) mengenai perawatan kesehatan ibu hamil (Shitah & Astuti, 2024).

Peran kader kesehatan merupakan salah satu komponen yang mendukung dalam upaya meningkatkan kesadaran kesehatan bagi ibu hamil. Melatih kader kesehatan masyarakat untuk mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi telah terbukti efektif. Dalam satu penelitian, kader kesehatan melaporkan peningkatan 100% dalam kemampuan mereka untuk mendeteksi kehamilan berisiko tinggi, yang mengarah pada rujukan tepat waktu ke layanan Kesehatan. Kader-kader ini

berfungsi sebagai penghubung penting antara penyedia layanan kesehatan dan keluarga, memastikan bahwa wanita hamil menerima dukungan dan pendidikan yang diperlukan (Irawati, 2022).

Pentingnya sistem dukungan formal dan informal disorot dalam penelitian dari India, yang menemukan bahwa dukungan sosial secara signifikan berdampak pada hasil kesehatan ibu. Peserta sangat bergantung pada petugas kesehatan masyarakat dan keluarga untuk bimbingan selama kehamilan. Dukungan yang ditingkatkan dapat mengatasi kesenjangan informasi, terutama selama fase persalinan dan pascapersalinan, meningkatkan kesadaran dan hasil kesehatan ibu (Sharma et al., 2023).

Pendampingan dapat dilakukan sejak awal kehamilan hingga setelah melahirkan. Selama masa kehamilan, kader melakukan pendampingan dengan memantau kondisi ibu dan memotivasi ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur dan melahirkan di layanan kesehatan yang sesuai dengan risiko kehamilan. Ibu hamil yang selalu melakukan pemeriksaan secara teratur akan terdeteksi secara dini jika ada komplikasi kehamilan, agar dapat segera dilakukan penanganan terhadap komplikasi kehamilan tersebut (Yani et al., 2021).

E. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Ibu Hamil

Pemberdayaan ekonomi dan sosial wanita hamil adalah strategi penting untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mereka. Inisiatif pemberdayaan, terutama melalui dukungan ekonomi, telah menunjukkan dampak positif yang signifikan pada perilaku kesehatan wanita hamil dan penyerapan perawatan antenatal (ANC).

Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan ekonomi perempuan berkorelasi positif dengan peningkatan kunjungan ANC, menunjukkan bahwa kemandirian finansial meningkatkan akses ke layanan Kesehatan. Memberdayakan perempuan secara ekonomi dapat mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik, karena memungkinkan mereka untuk memprioritaskan dan membayar perawatan kesehatan yang diperlukan selama kehamilan (Suh et al., 2023).

Selain itu faktor-faktor seperti kepuasan pernikahan dan dukungan spiritual secara signifikan mempengaruhi pemberdayaan ibu, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil kesehatan selama kehamilan. Kesadaran akan faktor penentu pemberdayaan ibu dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengembangkan program untuk mempromosikan pemberdayaan ibu selama masa kehamilan. Tampaknya dengan mengembangkan program konseling dan pendidikan dengan fokus khusus pada pengurangan kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kepuasan pernikahan serta menawarkan dukungan spiritual dapat lebih

memberdayakan wanita hamil. Peningkatan kesadaran dan hasil kesehatan mempromosikan pemberdayaan prenatal yang hasilnya dapat memfasilitasi ibu menuju ke arah kehamilan yang aman (Borghei et al., 2017).

F. Simpulan

Sangat penting meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan wanita hamil untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Beberapa strategi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran ini, dengan fokus pada pendidikan, teknologi, keterlibatan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi dan sosial ibu hamil. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan dan mempromosikan praktik sehat selama kehamilan. Pendidikan prenatal adalah program penting yang mempersiapkan calon orang tua dari masa kehamilan hingga persalinan, yang bertujuan mengenalkan komponen kehamilan dan persalinan serta mempersiapkan perawatan bayi baru lahir. Program ini mencakup aspek komprehensif meliputi pemantauan kesehatan kehamilan, edukasi nutrisi dan gaya hidup sehat, persiapan persalinan, teknik menyusui, perawatan bayi, dukungan psikologis, dan penguatan hubungan pasangan. Penyampaian dapat melalui pengalaman keluarga atau media digital. Keberhasilan program didukung oleh teknologi seperti aplikasi seluler dan sistem pemantauan IoT, serta penguatan sistem dukungan keluarga dan masyarakat. Peran kader kesehatan sebagai penghubung antara layanan kesehatan dan keluarga juga sangat penting, terutama dalam mendeteksi kehamilan berisiko tinggi. Faktor pemberdayaan ekonomi, dukungan keluarga, kepuasan pernikahan, dan dukungan spiritual turut berkontribusi pada efektivitas program dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

G. Referensi

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (2nd ed.). Unpad Press.
- Alotaibi, M., Albalawi, M., & Alwakeel, L. (2018). A Smart Mobile Pregnancy Management and Awareness System for Saudi Arabia. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 12(5), 112. <https://doi.org/10.3991/ijim.v12i5.9005>
- Amin, F., Ahmad Tali, T., Amin, H., & Ara, R. (2024). Fundamentals of prenatal care: A comprehensive guide to essential visits, screenings, and key guidelines for a healthy pregnancy. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 13(10), 2987–2991. <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20242848>

- Bellizzi, S., Panu Napodano, C. M., & Murgia, P. (2024). Family-centered care for newborns: A global perspective and review. *Journal of Tropical Pediatrics*, 70(5), fmae026. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmae026>
- Borghei, N. S., Taghipour, A., Roudsari, R. L., & Nooghabi, H. J. (2017). Investigating the Determinants of Maternal Empowerment during Pregnancy: A Strategy for Prenatal Healthcare Promotion. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 5(3), 988–997. <https://doi.org/DOI: 10.22038/jmrh.2016.7980>
- Da Silva, F. C., & Rodrigues, G. M. (2022). Standards In Prenatal Care. In R. A. Moreira De Sá & E. B. D. Fonseca (Eds.), *Perinatology* (pp. 157–169). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83434-0_10
- Dangol, A., Shrestha, R., Bhandari, B., Yakha, B. M., & Pandey, S. (2023). Knowledge and Practice Regarding Newborn Care among Postnatal Mother in Selected Community, Bhaktapur. *Journal of Advanced Academic Research*, 10(1), 63–74. <https://doi.org/10.3126/jaar.v10i1.54619>
- Gitas, G., Proppe, L., Ertan, A. K., Baum, S., Rody, A., Kocaer, M., Dinas, K., Allahqoli, L., Laganà, A. S., Sotiriadis, A., Sommer, S., & Alkatout, I. (2021). Influence of the second stage of labor on maternal and neonatal outcomes in vaginal births after caesarean section: A multicenter study in Germany. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 356. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03817-2>
- Gontasz, M. M., Keiser, A. M., & Aucott, S. W. (2024). Care of the Newborn. In *Avery's Diseases of the Newborn* (pp. 173–191.e6). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-82823-9.00016-7>
- Handayani, E. P., Jannah, M., & Rahmawati, A. (2023). Efforts To Increase Pregnant Women's Knowledge About High-Risk Pregnancy With Health Education. *Pharmacology, Medical Reports, Orthopedic, And Illness Details (Comorbid)*, 1(4), 14–21. <https://doi.org/10.55047/comorbid.v1i4.591>
- Irawati, D. (2022). Empowerment Of Community (Health And Family Cadres) In Early Detection Of High Risk Pregnant Mothers As A Prevention Of Pregnancy Complications. *Frontiers in Community Service and Empowerment*, 1(3). <https://doi.org/10.35882/ficse.v1i3.9>
- Kemenkes. (2018). *Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan di Fasilitas Kesehatan atau Puskesmas*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kehamilan-anc-di-fasilitas-kesehatan>
- Kemenkes. (2023). *BUKU KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK*. Kemenkes RI.
- Kemenkes. (2024). *BUKU KIA KESEHATAN IBU DAN ANAK*. Kemenkes RI.
- Liu, L., Pu, Y., Fan, J., Yan, Y., Liu, W., Luo, K., Wang, Y., Zhao, G., Chen, T., Puiiu, P. D., & Huang, H. (2024). Wearable Sensors, Data Processing, and Artificial Intelligence in Pregnancy Monitoring: A Review. *Sensors*, 24(19), 6426. <https://doi.org/10.3390/s24196426>

- Mandryk, I., & Węgrzyn, I. (2023). Awareness of pregnant women about proper nutrition habits and rational diet. *Journal of Education, Health and Sport*, 16(1), 49–61. <https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.16.01.006>
- Nolan, M. (2020). *Antenatal education: Sustaining healthy families* (2nd Edition). Taylor & Francis Group. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429290558-14/antenatal-education-mary-nolan>
- Nuraida, I., & Putri, D. L. (2024). Edukasi Kesehatan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil dan Kesehatan Balita. *TAAWUN*, 4(01), 85–92. <https://doi.org/10.37850/taawun.v4i01.595>
- Pangestuti, R., Ratrikaningtyas, P. D., & Sutomo, A. H. (2024). *Monitoring of Pregnant Women Using Mobile Application REST (Risk identification, Evaluation counseling, Systematic monitoring, Troubleshooting): Protocol for Cluster Randomized Controlled Trial* (Preprint). <https://doi.org/10.2196/preprints.66774>
- Samonte, M. J. C., Franco, B. S. F. F., Ocampo, H. A., & Rodriguez, M. A. F. (2023). IoT-based Pregnancy Health Monitoring System. *Proceedings of the 2023 6th International Conference on Information Science and Systems*, 281–290. <https://doi.org/10.1145/3625156.3625196>
- Sharma, P., Bagga, R., Khan, M., Duggal, M., Basavarajappa, D. H. B. H., Ahuja, A., Kankaria, A., Diamond-Smith, N., Kumar, V., Kashyap, M., Singh, P., Kaur, J., & Ayadi, A. E. (2023). *Maternal health education and social support needs across the perinatal continuum of care in India: A thematic analysis*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2721467/v1>
- Shitah, S. A.-F., & Astuti, I. (2024). Program Inovasi Pengabdian Masyarakat: Pelayanan Komprehensif Kesehatan Ibu Hamil (GEBUKIN-Gerakan Ibu Hamil Sadar Pemeriksaan Kesehatan) di Wilayah Kerja UPDT Puskesmas Tumbang Kajamei Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(8), 1449–1457. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i8.7173>
- Suh, H., Kalai, S., Trivedi, N., Underwood, C., & Hendrickson, Z. M. (2023). Effects of women's economic empowerment interventions on antenatal care outcomes: A systematic review. *BMJ Open*, 13(3), e061693. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061693>
- Supraja, A., Vasavi, A. D., & Karthikeyan, K. V. (2023). Pregnant Women Health Monitoring System. *2023 International Conference on Advances in Computing, Communication and Applied Informatics (ACCAI)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ACCAI58221.2023.10200921>

- UNICEF. (2019). *Healthy Mothers, Healthy Babies: Taking stock of maternal health*. New York; 2019. Available from: [https:// data. unicef. org/ resou rces/ healt hymothers- healt hy- babies/](https://data.unicef.org/resources/healthy-mothers-healthy-babies/)
- Wanduru, P., Hanson, C., Kwesiga, D., Kakooza-Mwesige, A., Mölsted Alvesson, H., & Waiswa, P. (2024). Parental participation in newborn care in the view of health care providers in Uganda: A qualitative study. *Reproductive Health*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01896-w>
- WHO, UNICEF U, & TWB. (2019). *Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2017*. Geneva
- Yani, L. Y., Merbawani, R., & Munfadlila, A. W. (2021). Empowering Health Cadres on Nutrition Education for Pregnant Women in Industrial Areas during the Pandemic. *Jurnal Ners*, 16(2), 177–182. <http://dx.doi.org/10.20473/jn.v16i2.26674>
- Yoseph, A., Teklesilasie, W., Guillen-Grima, F., & Astatkie, A. (2023). *Effect of Community-Based Health Education Led by Women's Groups on Mothers' Knowledge of Obstetric Danger Signs and Birth Preparedness and Complication Readiness Practices in Southern Ethiopia: A Cluster Randomized Controlled Trial*. <https://doi.org/10.20944/preprints202312.1154.v1>
- Yunitasari, E., Matos, F., Zulkarnain, H., Kumalasari, D. I., Kusumaningrum, T., Putri, T. E., Yusuf, Ah., & Astuti, N. P. (2023). Pregnant woman awareness of obstetric danger signs in developing country: Systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 357. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05674-7>

H. Glosarium

AKB = Angka Kematian Bayi
 AKI = Angka Kematian Ibu
 ANC = *Antenatal Care*
 BBLR = Berat Badan Lahir Rendah
 CFD = *Cephalopelvic Disporstion*
 EKG = Elektrokardiogram
 GEBUKIN = Gerakan Ibu Hamil Sadar Pemeriksaan Kesehatan
 GSM = *Global System for Mobile*
 IoT= *Internet of Things*
 KEK = Kekurangan Energi Kronis
 KIA = Kesehatan Ibu dan Anak
 MDGs = *Millennium Development Goals*
 RCT = *Randomized Controlled Trial*
 REST = *Risk identification, Evaluation counseling, Systematic monitoring, Troubleshooting*

SDGs = *Sustainable Development*

TTD = Tablet Tambah Darah

USG = Ultrasonografi

CHAPTER 4

KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Warini, S.ST., M.KM.

A. Pendahuluan/Prolog

Salah satu isu kesehatan global yang terus menjadi perhatian adalah tingginya angka kematian ibu. Meski setiap tahunnya terjadi penurunan rata-rata sebesar 2,9%, angka ini masih tidak memadai untuk mencapai sasaran angka kematian di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup yang ditargetkan pada tahun 2030 (Spencer, 2021). Data dari UNFPA mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah Asia Pasifik mencapai 127 per 100.000 kelahiran hidup, di mana hampir 92% dari kasus tersebut berasal dari negaranegara berkembang, termasuk Indonesia (Amalia, Lestari dan Ningrum, 2020). Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) di tahun 2015 menunjukkan AKI di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010, angka tersebut masih terlalu tinggi dan jauh dari target SDGs (Bappenas, 2017). Di tahun 2020, tercatat ada 4627 kematian ibu, dengan penyebab langsung seperti perdarahan (1330 kasus), hipertensi selama kehamilan (1110 kasus), gangguan pada sistem peredaran darah (230 kasus), sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain (Kemenkes RI, 2021).

Menurut GKIA (2016), di samping penyebab langsung, terdapat juga faktor tidak langsung yang berkontribusi pada kematian ibu, yang dikenal sebagai 4 terlambat dan 3 terlambat. Amalia et al. (2020) mencatat bahwa di negaranegara berkembang, keterlambatan dalam pengambilan keputusan merupakan masalah yang paling umum. Faktorfaktor yang mempengaruhi keterlambatan ini meliputi orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, faktor sosial budaya, serta kendala keuangan (Mgawadere et al., 2017). Salah satu aspek sosial budaya yang mempengaruhi akses serta pengalaman individu dalam mendapatkan layanan kesehatan adalah ketidaksetaraan gender (WHO, 2017).

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ada kemajuan dalam isu ketidaksetaraan gender, hasil yang dicapai masih jauh dari target yang ditetapkan oleh SDGs (BAPPENAS, 2019). Pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, sangat penting untuk mempercepat perubahan di negaranegara berkembang dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Alvarez, 2013;

Mitroi et al., 2016). Sebagai profesi kesehatan yang selalu bekerja sama dengan perempuan, bidan memiliki filosofi bahwa setiap perempuan harus diberdayakan melalui konseling dan informasi kesehatan untuk keputusan mengenai kesehatan mereka dan keluarga (IBI, 2016). Pada hari Bidan Sedunia tahun 2019, International Confederation of Midwives (ICM) menekankan peran penting bidan dalam melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan seksual (Soumokil, 2020). Literatur ini disusun untuk menyelidiki pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pelayanan kebidanan.

B. Kajian Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologi, kata pemberdayaan berasal dari istilah "daya," yang mengacu pada kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, pemberdayaan dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan dari individu atau kelompok yang kuat kepada mereka yang lemah atau belum berdaya.

Pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya perempuan agar menjadi lebih mandiri, serta mendorong setiap individu agar dapat memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Proses ini juga seharusnya fokus pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan yang berfokus pada peningkatan kekuatan individu atau kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk mereka yang terjebak dalam kondisi kemiskinan. Ini merupakan upaya untuk mencapai perubahan sosial yang diharapkan. Masyarakat yang berdaya memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti kepercayaan diri dan pekerjaan yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan individu, terutama bagi kelompok yang rentan dan lemah, sehingga mereka dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang serta jasa yang diperlukan.

- a. Menurut Habiba pada tahun 2022, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk masyarakat dengan maksud memperbaiki kemampuan mereka. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendorong atau memberi motivasi kepada individu agar mereka memiliki pengetahuan atau kemampuan

yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan mereka. Selain itu, fokus pemberdayaan harus pada kelompok atau lapisan masyarakat yang mungkin terpinggirkan atau kurang mendapatkan perhatian.

- b. Sementara itu, Poerwoko Soebiato dalam 2017 menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan keterampilan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dengan harapan agar mereka memperoleh kemampuan dan rasa percaya diri untuk menyampaikan pandangan, ide, atau gagasan mereka. Ini juga mencakup kemampuan serta keberanian untuk membuat pilihan yang tepat mengenai konsep, metode, produk, tindakan, dan hal lain yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi diri mereka, keluarga, dan komunitas sekitar.
- c. Menurut Abbasy (2021), pemberdayaan perempuan merupakan suatu hak bagi wanita sebagai individu untuk mengendalikan hidup mereka, menentukan prioritas dalam aktivitas, mengembangkan keterampilan pribadi, serta meningkatkan keyakinan pada kemampuan diri mereka
- d. Sementara itu, Andriani (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wanita untuk memperoleh akses dan penguasaan terhadap sumber daya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar wanita dapat mengelola diri mereka, membangun kepercayaan diri, serta berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah, sehingga mereka dapat memperkuat kemampuan serta identitas diri.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri. Tujuan dari semua ini adalah agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengeluarkan potensi mereka untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka.

Dari keterangan di atas ahli lain juga menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bertujuan memberikan wanita kendali atas hidup mereka dan akses ke berbagai sumber daya. Hal ini mencakup pengembangan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk aktif dalam menghadapi tantangan serta mengembangkan identitas yang lebih kokoh. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan memiliki peran krusial dalam mencapai kesetaraan gender dan perkembangan diri wanita.

2. Indikator Pemberdayaan

Menurut Nugroho pada tahun 2008, ada empat indikator utama yang berhubungan dengan pemberdayaan, yaitu:

- a. Akses, yang menunjukkan adanya kesetaraan hak untuk memperoleh sumber daya produktif dalam suatu lingkungan.
- b. Partisipasi, yang merujuk pada keikutsertaan individu dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang terbatas.
- c. Kontrol, berarti bahwa baik pria maupun wanita memiliki peluang yang sama untuk mengendalikan atau menggunakan sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya atau perkembangan, baik bagi pria maupun wanita secara adil dan bersamaan.

Sementara itu, menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Geovani di tahun 2021, ada beberapa indikator pemberdayaan yang meliputi:

- a. Kebebasan untuk Bergerak: Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk berpindah dari satu tempat tinggal ke tempat lain, seperti pasar, layanan kesehatan, bioskop, tempat ibadah, atau rumah tetangga. Mobilitas dianggap tinggi jika seseorang dapat bepergian sendiri.
- b. Kemampuan Membeli Barang Kecil: Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Kemampuan ini lebih terlihat jika individu dapat mengambil keputusan ini tanpa izin pasangan dan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan Membeli Barang Besar: Ini mengacu pada kapasitas individu untuk membeli barang kebutuhan sekunder atau tersier, seperti lemari, televisi, dan sejenisnya. Seperti indikator sebelumnya, individu yang dapat membuat keputusan ini sendiri dan menggunakan uangnya sendiri akan mendapatkan poin tinggi.
- d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Keluarga: Ini mencakup keterlibatan individu dalam keputusan penting rumah tangga, seperti merencanakan renovasi rumah atau terkait utang untuk usaha, dan lainlain.
- e. Kebebasan dari Pengaruh Keluarga: Ini menunjukkan seberapa jauh individu tidak tertekan atau terpengaruh oleh intervensi anggota keluarga lain, misalnya dalam menentukan jumlah anak.
- f. Pengetahuan Politik dan Hukum: Ini berkaitan dengan pemahaman tentang pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan, serta pentingnya dokumen administratif seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga.

- g. Keterlibatan dalam Aksi dan Protes: Salah satu indikator pemberdayaan adalah apakah individu pernah ikut serta dalam aksi kampanye atau protes bersama orang lain, contohnya dalam kasus kekerasan rumah tangga.

Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan mengenai berbagai indikator yang relevan dalam menilai pemberdayaan. Indikator-indikator ini mencakup aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat, kebebasan bergerak, kemampuan untuk membeli, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, kebebasan dari dominasi keluarga, pengetahuan politik dan hukum, serta partisipasi dalam kampanye dan protes. Semua indikator ini sangat penting untuk memahami dan menilai pemberdayaan individu dan komunitas.

3. Tahapan Proses Pemberdayaan Perempuan

Anggraini (2022) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Tahapan penyadaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi individu dalam mengembangkan kemampuan diri.
- b. Tahapan transformasi, di mana pembelajaran dilakukan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dasar yang sudah ada.
- c. Tahap peningkatan, di mana kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya mulai terlihat melalui inisiatif dan tindakan yang lebih mandiri.

Kabeer dalam Mayoux, menurut Geovani (2021), menyebutkan ada lima elemen utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Kesejahteraan: Ini merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, karena perempuan sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan terkait akses kesejahteraan.
- b. Akses: Merujuk pada kemampuan perempuan untuk mengklaim hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan sumber daya produktif seperti pinjaman, tanah, pelatihan, fasilitas, tenaga kerja, serta layanan publik yang setara dengan laki-laki.
- c. Konsientisasi: Mengacu pada pemahaman tentang perbedaan peran berdasarkan gender.
- d. Partisipasi: Menyiratkan kesetaraan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, administrasi, dan perencanaan, yang
- e. Kesetaraan dalam kekuasaan: Mengacu pada kesetaraan dalam penguasaan faktor-faktor produksi dan distribusi keuntungan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang setara.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan meliputi tahapan penyadaran, transformasi, dan peningkatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan individu. Selain itu, elemenelemen seperti kesejahteraan, akses, konsientisasi, partisipasi, dan kesetaraan dalam kekuasaan memiliki peran penting dalam pencapaian pemberdayaan perempuan. Dengan memahami dan menerapkan elemenelemen tersebut, pemberdayaan perempuan dapat direalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Jenis Kategori Pemberdayaan Perempuan

Menurut Suharjuddin (2020), terdapat lima kategori dalam pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Ekonomi: Tujuan dari jenis pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui berbagai program, termasuk usaha mikro dan pinjaman modal.
- b. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pertanian: Pemberdayaan di sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Ini mencakup inovasi dan perubahan besar dalam pertanian di Indonesia.
- c. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Kesehatan: Di sektor kesehatan, fokusnya adalah untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai masalah kesehatan. Ini meliputi promosi program kesehatan, penyuluhan, dan perbaikan infrastruktur kesehatan.
- d. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan: Pendidikan adalah alat penting untuk memahami berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan di sektor pendidikan mencakup pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten serta peningkatan fasilitas pendidikan.
- e. Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Agama: Tujuan pemberdayaan di sektor ini adalah untuk mengakui dimensi spiritual individu sebagai bagian penting dari mencapai keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.

Sedangkan menurut Draha dalam Anggraini (2022), ada empat kategori pemberdayaan yang meliputi:

- a. Pemberdayaan Politik: Tujuan dari pemberdayaan politik adalah untuk meningkatkan pengaruh dalam pemerintahan.
- b. Pemberdayaan Ekonomi: Ini berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi sebagai respons terhadap kegagalan program dan tantangan pembangunan.
- c. Pemberdayaan Sosial Budaya: Kategori ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manusia dengan berinvestasi dalam pengembangan aspek manusia, untuk menaikkan nilai-nilai kemanusiaan.

- d. Pemberdayaan Lingkungan: Pemberdayaan lingkungan melibatkan program untuk merawat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan mencakup berbagai jenis, termasuk ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, agama, politik, sosial budaya, dan lingkungan. Tujuan dari semua ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pengaruh politik, pertumbuhan ekonomi, kapasitas manusia, dan perlindungan lingkungan. Dengan memahami berbagai jenis pemberdayaan ini, upaya yang komprehensif dapat dilakukan untuk meningkatkan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat.

5. Aspek Pemberdayaan Perempuan

Menurut Suharto dalam (Anggraini, 2022), terdapat lima aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Motivasi: Tujuan dari motivasi adalah untuk memberi semangat kepada orang-orang agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka, khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki. Ini terkait dengan kemampuan mereka untuk memahami nilai-nilai kerja sama, interaksi sosial, dan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat.
- b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Keterampilan: Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran melalui berbagai cara, seperti perbaikan kesehatan, sanitasi, imunisasi, dan pendidikan dasar. Keterampilan vokasional dapat ditingkatkan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan. Selain itu, pengetahuan lokal dapat diperluas dengan menggabungkan pengalaman pribadi dengan pengetahuan dari luar.
- c. Manajemen Diri: Di tahap awal, bimbingan dari pihak luar dapat membantu membangun sistem pengaturan kelompok. Namun, setelah itu, kelompok tersebut diberikan kebebasan penuh untuk mengelola dan menyusun sistem tersebut sendiri.
- d. Mobilitas Sumber Daya: Pengembangan tabungan secara rutin dan sumbangan sukarela adalah cara untuk menggerakkan sumber daya dan menciptakan modal sosial. Konsep ini berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki sumber daya yang, jika digabungkan, dapat sangat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- e. Pembangunan dan Pengembangan Jejaring: Membangun dan memperluas jaringan sangat penting dalam memberikan akses kepada sumber daya dan peluang yang mendukung pemberdayaan komunitas yang kurang beruntung.

Sementara itu, menurut (Anggraini, 2022), ada empat aspek penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, yaitu:

- a. Kesetaraan: Kesetaraan mengacu pada pengakuan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara. Melalui hubungan yang setara, terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Hal ini memungkinkan setiap individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta mendorong proses pembelajaran bersama.
- b. Partisipasi: Partisipasi adalah tindakan aktif yang harus selalu ada dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Ini menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok dalam semua tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- c. Kemandirian: Kemandirian merupakan langkah penting dalam pertumbuhan individu. Ini mencerminkan keberanian untuk mengambil keputusan dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Sikap ini diperlukan agar individu atau kelompok dapat mencapai kemajuan dalam setiap proses yang dilalui.
- d. Keberlanjutan: Setiap program yang dijalankan harus memiliki visi jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan nilai dan mencapai hasil yang bermanfaat sebagai salah satu tujuan utama.
- b. Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan melibatkan berbagai aspek kunci seperti motivasi, peningkatan kesadaran, manajemen diri, mobilitas sumber daya, pembangunan jejaring, kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Semua elemen ini merupakan bagian yang sangat penting untuk memperkuat peran dan posisi perempuan dalam masyarakat serta mencapai kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan.

6. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho dalam (Geovani, 2021), ada beberapa tujuan untuk memberdayakan perempuan dalam masyarakat, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan perempuan agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
- b. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha mikro (UKM) dan industri besar, dengan tujuan meningkatkan pendapatan individu dan keluarga, membuka peluang pekerjaan, serta memperkuat kemandirian.
- d. Meningkatkan posisi serta peran organisasi atau kelompok perempuan di tingkat lokal sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan lainnya.

Di sisi lain, tujuan pemberdayaan perempuan menurut (Sumodiningrat, 1999) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keberadaan perempuan, yaitu kesadaran akan hak-hak mereka yang sama dengan laki-laki. Tujuannya adalah untuk mencegah posisi tertekan

yang kerap dialami oleh perempuan, serta memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.

- b. Memberi motivasi kepada perempuan agar mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam memilih hidup mereka melalui dialog. Perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri, tanpa harus selalu mengikuti keinginan laki-laki.
- c. Meningkatkan kesadaran perempuan tentang kesetaraan dan status mereka, baik dalam bidang publik maupun di lingkungan rumah tangga.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pandangan para ahli di atas adalah bahwa tujuan pemberdayaan perempuan meliputi upaya untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, manajemen usaha, serta posisi dan peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu, tujuan ini juga mencakup pemberian kesempatan, kemandirian, dan kesadaran mengenai hak-hak yang setara dengan laki-laki. Semua tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat serta memberikan mereka peluang yang lebih besar untuk tumbuh secara pribadi dan profesional.

7. Indikator Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nisa (2020), ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan, yaitu:

- a. Akses, yang berarti hak yang setara dalam lingkungan tertentu.
- b. Partisipasi, yang merujuk pada keterlibatan dalam penggunaan sumber daya atau aset yang terbatas.
- c. Kontrol, yang menunjukkan bahwa pria dan wanita seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya tersebut.
- d. Manfaat, artinya baik pria maupun wanita harus bisa menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya atau kegiatan pembangunan secara bersamaan dan adil.

Di samping itu, Yosetya (2022) menyebutkan lima indikator pemberdayaan perempuan yang diatur oleh G20 Empower, yaitu:

- a. Pembagian peran yang merata antara pria dan wanita di semua level pekerjaan.
- b. Persentase wanita yang mendapatkan promosi di posisi tertentu.
- c. Total kesenjangan remunerasi antara gender.
- d. Persentase wanita di posisi direksi dalam perusahaan.
- e. Persentase wanita yang terlibat dalam pekerjaan teknis.

Dari pandangan para ahli, bisa disimpulkan bahwa indikator pemberdayaan perempuan mencakup aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, dengan pendidikan wanita sebagai kunci kesuksesan dalam pemberdayaan. Selain itu,

keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk di politik, juga merupakan indikator penting untuk mengukur pemberdayaan perempuan. Semua ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan peningkatan peran serta posisi perempuan dalam masyarakat.

C. Kolaborasi Lintas Sektor Dalam Pemberdayaan Perempuan

Kerjasama antar sektor dalam memajukan perempuan merupakan kerjasama antara berbagai pihak untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan menjaga hak-haknya. Tujuan dari kerjasama lintas sektor ini adalah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan, memperbaiki perlindungan hak-hak perempuan, meningkatkan kualitas data mengenai gender, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kolaborasi antar berbagai sektor dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam layanan kebidanan melibatkan kerjasama sejumlah lembaga dan organisasi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi perempuan. Pendekatan ini sangat penting untuk menangani masalah kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, dengan melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.

1. Contoh Bentuk Kolaborasi dengan Pemerintah

Kementerian PPPA dalam Siaran Pers Nomor: B207/SETMEN/HM. 02. 04/7/2024 menyampaikan tema "Libatkan Sinergi Lintas Pihak, Wujudkan Kesejahteraan Ibu dan Anak" dan akan mendirikan Panitia Antar Kementerian (PAK). Tujuan panitia ini adalah untuk mengawasi penyusunan empat peraturan turunan dari UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Ini bertujuan agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Keempat peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah mengenai Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Diperlukan adanya strategi pentahelix dalam penerapan UU KIA di Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Penting untuk melibatkan bukan hanya Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, tetapi juga keluarga, khususnya para ibu.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar bagi ibu dan anak. Ini mencakup peningkatan perhatian dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, mendorong kemandirian, keberdayaan, dan ketahanan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kepemimpinan komunitas. Selain itu, perlu ada peningkatan kepedulian sosial, empati, dan semangat gotong royong, serta pengembangan budaya lokal untuk kesejahteraan ibu dan anak.

Dalam penyelenggaraan KIA terdapat beberapa komponen seperti perencanaan, pelaksanaan, penyediaan layanan gratis, pengawasan, dan

evaluasi, serta koordinasi. Secara lebih rinci, pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak meliputi (a) layanan kesehatan dan gizi, (b) pelayanan keluarga berencana, (c) bantuan kesejahteraan sosial, (d) rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial, (e) layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (f) layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan serta keluarga, (g) kemudahan dalam akses fasilitas dan akomodasi yang layak, (h) kesempatan untuk belajar, mendapatkan pendidikan, dan pendampingan, (i) menciptakan lingkungan yang ramah ibu dan anak serta memberikan perlindungan, dan/atau (j) kemudahan dalam layanan hukum.

Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan dukungan kepada ibu dalam menyiapkan kehamilan, menjalani masa hamil, bersalin, hingga masa setelah melahirkan. Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk ibu, tetapi juga kepada anak selama fase seribu hari pertama kehidupan. Dukungan ini bisa bersifat fisik, emosional, sosial, hingga spiritual.

2. Contoh Kolaborasi antar instansi

Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa melibatkan perempuan dari daerah setempat, dengan fokus pada tugas dan fungsinya. Proses ini dibantu oleh Tim Fasilitator Kecamatan yang menekankan hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- b. Mengarahkan dan memperkuat kemampuan kelompokkelompok PKK di Dusun, Lingkungan, RW, RT, dan Dasawisma untuk merealisasikan program yang telah disiapkan.
- c. Menggali serta mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan penyuluhan kepada keluarga dengan melibatkan bimbingan dan motivasi untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
- e. Menyediakan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program kerja.
- f. Mengikutsertakan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga di desa atau kelurahan.
- g. Menyusun laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- h. Menerapkan sistem administrasi yang teratur.
- i. Menyediakan konsultasi.

Selanjutnya, terdapat Program Kerja yang berfokus pada Pengelolaan Kesehatan, Pelestarian Lingkungan, dan Perencanaan Sehat. Tugas dalam program ini meliputi:

- a. Meningkatkan hasil dari tujuan pembangunan milenium.
- b. Memperkuat budaya hidup bersih dan sehat.

- c. Merencanakan serta mengelola kegiatan POSYANDU.
- d. Memantau pelaksanaan Sistem Informasi untuk POSYANDU.
- e. Mendata informasi mengenai ibu hamil, melahirkan, masa nifas, kematian ibu, serta kelahiran dan kematian bayi dan anak kecil.
- f. Menanam dan merawat pohon untuk mendukung pelestarian alam.
- g. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan makmur melalui program Keluarga Berencana guna menghasilkan generasi yang sehat, pintar, dan tangguh.
- h. Meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup hemat, membiasakan menabung, dan mengelola keuangan keluarga untuk mendukung perencanaan yang sehat.

Prioritas Program: Kesehatan

- a. Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi untuk menurunkan jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi.
- b. Memberikan nutrisi yang seimbang kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- c. Meningkatkan kualitas gizi bagi ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas.
- d. Menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh kekurangan garam yodium.
- e. Memberikan suplemen gizi.
- f. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan.
- g. Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).
- h. Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita dan Lansia di Posyandu.
- i. Menyediakan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS).
- j. Menambah kalori (Protein, Karbohidrat, Lemak, Vitamin, Mineral, Air) di sekolah.
- k. Membudayakan PHBS sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.
- l. Meningkatkan pemahaman tentang Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) untuk menurunkan angka kematian anak dan ibu.
- m. Meningkatkan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) tentang manfaat penggunaan kontrasepsi.
- n. Mengembangkan penyuluhan terkait pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
- o. Mendorong penanaman dan perawatan pohon untuk menjaga lingkungan, serta mengurangi dampak pemanasan global.
 - p. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBAL).

- q. Pemahaman tentang administrasi yang baik untuk meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dalam keluarga.
- r. Mengoptimalkan Posyandu.
- s. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga.
- t. Meningkatkan penyuluhan untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, penyakit DBD, Malaria, Osteoporosis, Gondok, Anemia pada ibu hamil, Penyakit Degeneratif seperti Jantung dan Diabetes, Kanker, Stroke, TB, Penyakit Infeksi, dan lainnya.

3. Contoh Kolaborasi dengan Swasta

Bank atau institusi keuangan swasta bisa bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah untuk memberikan akses kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil. Kerja sama ini dapat meliputi pelatihan serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari hasil pelatihan. Selain itu, pihak swasta juga dapat melakukan hal yang sama dalam hal pembiayaan dan penyediaan fasilitas untuk penyuluhan kesehatan, terutama di bidang kesehatan, khususnya kebidanan.

4. Contoh Kolaborasi dengan Masyarakat

- a. Mendukung kerja sama dengan masyarakat.

Setiap inisiatif dalam kesehatan sebaiknya dilakukan dengan prinsip bekerja bagi dan bersamaan dengan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan semangat dan kemampuan masyarakat melalui bimbingan, motivasi, serta transfer pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan kepada mereka.

- b. Mengalihkan hak pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Semua usaha untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di sektor kesehatan, perlu berlandaskan pada budaya dan tradisi setempat agar dapat berhasil dan berkelanjutan. Untuk itu, keputusan mengenai cara pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat sebaiknya diserahkan kepada mereka. Pemerintah atau tenaga kesehatan berfungsi sebagai fasilitator dan pendorong. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab atas pelaksanaan, dengan mereka menjadi subjek dan bukan objek dalam proses pembangunan.

- c. Membangun kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat setempat.

Prinsip lain dari pemberdayaan di bidang kesehatan adalah pemerintah atau petugas kesehatan perlu bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, usaha untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat akan lebih efektif dan efisien.

- d. Melaksanakan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, serta pelatihan dan penyuluhan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi lokal.
- e. Desentralisasi sesuai dengan konteks dan budaya setempat.

Peran perempuan dalam pembangunan negara semakin diakui dan semakin penting dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini terjadi bersamaan dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan politik yang telah dilalui oleh Indonesia dalam sejarah modern. Perempuan kini bukan hanya sebagai penyeimbang dalam keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan yang krusial.

Namun, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam peran mereka di pembangunan bangsa. Kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan kesehatan, diskriminasi di tempat kerja, serta berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di banyak lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama dari semua pihak untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan bangsa.

Dengan memberdayakan perempuan melalui program-program tersebut, kita sedang membangun masa depan bangsa. Perempuan yang memiliki kekuatan dapat memberikan dampak positif dalam banyak hal, baik di lingkungan keluarga, komunitas, hingga dalam pengembangan nasional.

D. Simpulan

Masalah kesehatan global yang masih mendapat perhatian adalah tingginya angka kematian ibu. Meskipun ada penurunan rata-rata 2,9% setiap tahun, penurunan ini masih belum cukup untuk memenuhi target kematian di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup yang ditetapkan untuk tahun 2030. Sebagai profesi kesehatan yang selalu bekerja sama dengan perempuan, bidan memiliki filosofi bahwa setiap perempuan harus diberdayakan melalui konseling dan informasi kesehatan untuk keputusan mengenai kesehatan mereka dan keluarga, sebagai salah satu upaya penurunan angka kematian ibu. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya perempuan agar menjadi lebih mandiri, serta mendorong setiap individu agar dapat memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Proses ini juga seharusnya fokus pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dengan memberdayakan perempuan melalui program-program yang ada, kita sedang membangun masa depan bangsa. Perempuan yang memiliki kekuatan dapat memberikan dampak positif dalam banyak hal, baik di lingkungan keluarga, komunitas, hingga dalam pengembangan nasional.

E. Referensi

- Abbasy (2021) Pemberdayaan Perempuan Melalui Program batik tulis(Studi Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Basmala Desa TambakanKecamatan Gubug Kabupaten Grobogan)
- Afulani, P. A. et al. (2017) "Conceptualizing pathways linking women ' s empowerment and prematurity in developing countries," 17(Suppl 2). doi: 10.1186/s12884-017-1502-6.
- Alvarez, M. L. (2013) From Unheard Screams To Powerful Voices: a Case Study of Women'S Political Empowerment in the Philippines. Tersedia pada: <http://nap.psa.gov.ph/>.
- Amalia, S. R., Lestari, P. dan Ningrum, A. G. (2020) Faktor Penyebab Keterlambatan Rujukan Maternal Studi Systematic Review Dengan Framework Tiga Terlambat. Universitas Airlangga.
- Astuti, K. . E. W., Tajmiati, A. dan Suryani, E. (2016) Konsep Kebidanan dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Bappenas (2017) "Kehidupan sehat dan sejahtera," Kementrian PPN. Tersedia pada: <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>.
- BAPPENAS (2013) "Analisis Gender dalam Pembangunan Kesehatan," Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), hal. 1689–1699.
- Bappenas (2019) "Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian-Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2019,"
- Candrawati, R.D. *et al.* (2023) Promosi Dan Perilaku Kesehatan. Casnuri, Novika, Almira Gitta, dkk (2022) Asuhan Kebidanan Komunitas. Banyumas: Pena Persada.
- Cunningham, K. et al. (2015) "Review Article Women ' s empowerment and child nutritional status in South Asia : a synthesis of the literature," hal. 1–19. doi: 10.1111/mcn.12125.
- Darwis and Marsofely, R.L. (2022) Membangun Kemitraan Kesehatan. Cirebon: Green Publisher Indonesia.
- Dhak, B. (2019) "Contraceptive use and its effect on Indian women ' s empowerment :evidence from the National Family Health Survey-4."doi: 10.1017/S0021932019000609.
- Dian Hidayati. (2021). Model pemberdayaan dan kemandirian perempuan. Diakses dari <https://etheses.uinmataram.ac.id/5057/1/DIAN%20HIDAYATI%20%28190105053.pdf>

- Dickson, K. S. (2021) "Women Empowerment and Skilled Birth Attendants among Women in Rural Ghana," 2021.
- DP3AP2KB (2020) Pengarusutamaan Gender Adalah Strategi Integrasi Gender Bukan Suatu Program atau Kegiatan. Tersedia pada:
<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2020/07/16/pengarusutamaan-gender-adalah-strategi-integrasi-gender-bukan-suatu-program-atau-kegiatan/>
 (Diakses: 18 Mei 2021).
- GKIA (2016) 1001 Langkah Selamatkan Ibu dan Anak. I. Diedit oleh D. R. Fajar. Jakarta: Pustaka Bunda.
- Habiba B.D (2022)"Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Kesetaraan Di Gampong Lempoh Daya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh"
- Haddad, L. M. dan Butler, T. J. T. (2020) Empowerment - StatPearls - NCBI Bookshelf. Tersedia pada: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430929/> Diakses: 29 April 2021).
- Hadisuyatmana, S. et al. (2021) "Women ' s Empowerment and Determinants of Early Initiation of Breastfeeding : A Scoping Review," Journal of Pediatric Nursing, 56, hal. e77–e92. doi: 10.1016/j.pedn.2020.08.004.
- Heise, L. et al. (2019) "Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health," The Lancet, 393(10189), hal. 2440–2454. doi:10.1016/S0140- 6736(19)30652-X.
- IBI (2016) Filosofi Kami. Tersedia pada: https://ibi.or.id/id/article_view/A20150112002/filosofi-kami.html (Diakses: 5 April 2021).
- Izzatul Ainiyah,(2022)Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pelayanan Kebidanan: Literature Review.
- J Giovanni, P Subianto (2023) Pengembangan Konseptual Model Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian UMKM di Kota Palangka Raya
- Jennings, L. et al. (2014) "Women ' s empowerment and male involvement in antenatal care : analyses of Demographic and Health Surveys (DHS) in selected African countries," hal. 1–11.
- Kabir, A. et al. (2020) "Women ' s empowerment is associated with maternal nutrition and low birth weight : evidence from Bangladesh Demographic Health Survey," hal. 1–12.
- Kawaguchi, L. et al. (2014) "DIMENSIONS OF WOMEN ' S EMPOWERMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE UTILIZATION OF MATERNAL HEALTH SERVICES IN AN EGYPTIAN VILLAGE :A MULTIVARIATE ANALYSIS," Nagoya J. Med. Sci, 76, hal. 161–171.
- Kemenkes RI (2021) Profil Kesehatan Indonesia 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://pusdatin.kemkes.go.id/res>

ources/download/pusdatin/profil -kesehatan-indonesia/Profil- Kesehatan-Indonesia-Tahun- 2020.pdf.

- Khatiwada, J. et al. (2020) "Dimensions of women ' s empowerment on access to skilled delivery services in Nepal," 9, hal. 1–13.
- Kibret, S. et al. (2020) "Associations between women ' s empowerment and children ' s health status in Ethiopia," hal. 1–24. doi: 10.1371/journal.pone.0235825.
- Loenzien, M. De et al. (2021) "Women ' s empowerment and elective cesarean section for a single pregnancy : a population-based and multivariate study in Vietnam," hal. 1–12.
- M Marthalina. (2018). Pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro kecil. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/862/546>
- Mekonnen, A. G. et al. (2021) "Women ' s empowerment and child growth faltering in Ethiopia : evidence from the Demographic and Health Survey," BMC Women's Health, hal. 1–9. doi: 10.1186/s12905-021-01183-x.
- Mgawadere, F. et al. (2017) "Factors associated with maternal mortality in Malawi: Application of the three delays model," BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1), hal. 1–9. doi: 10.1186/s12884-017-1406-5.
- Mie, N. et al. (2021) "Empowerment and health care access barriers among currently married women in Myanmar," hal. 1–9.
- Mishra, A. D. (2014) "Women Empowerment: Issues and Challenges," Indian Journal of Public Administration, 60(3),hal.398–406.doi: 10.1177/0019556120140302.
- Mitroi, L. R. et al. (2016) "The Women's Health Care Empowerment Model as a Catalyst for Change in Developing Countries," Health Care for Women International, 37(3), hal. 273–287. doi: 10.1080/07399332.2014.926903
- N Mutmainah. (2020). Keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26844/1/NURUL%20MUTMAINAH-FDK.pdf>
- Novianty, A. (2017) Buku ajar konsep kebidanan, Jakarta: EGC.
- Nurmala, I. et al. (2018) Buku Promosi Kesehatan. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Poerwoko Soebiato (2017) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Putra, I. G. N. E., Dendup, T. dan Januraga, P. P. (2020) "The roles of women empowerment on attitude for safer sex negotiation among Indonesian married women negotiation among Indonesian married women," Women & Health, 00(00), hal. 1–14. doi: 10.1080/03630242.2020.183168
- Rachmawati, W. C. (2019) Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Malang: Wineka Media.

- Samari,G.(2019) "Women's Empowerment and Short and Long-acting Contraceptive Methode Use in Egypt," *Cult Health Sex*, 20(4), hal. 458–473. doi: 10.1080/13691058.2017.1356938.Women.
- Santoso, M. V et al. (2019) "Role of Women ' s Empowerment in Child Nutrition Santi Zuli Yana. (2008). Strategi dinas pemberdayaan perempuan. Diakses dari <https://repository.arraniry.ac.id/37718/1/Santi%20Zuli%20Yana%2C%20200802009%2C%20FISIP%2C%20IAN.pdf> Outcomes : A Systematic Review," hal. 1138– 1151.
- Soumokil, M. (2020) "Peran Bidan Dalam Implementasi Women Centered Care (Asuhan Yang Berpusat Pada Perempuan) Latar Belakang," hal. 1–20.
- Spencer, J. (2021) "The Sustainable Development Goals," *Design for Global Challenges and Goals*, hal. 12–25. doi: 10.4324/9781003099680-3.
- Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengharusutamaan*nya (Novrian, Ed.; 1st ed.). Pena Persada.
- Suryani, Desri, Y. (2022) *Advokasi Pelayanan Kesehatan*, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Tyson, N. A. (2019) "Reproductive Health Women: Options, Strategies, and Empowerment of Women," *Obstetrics and Gynecology Clinics of NA*, 46(3), hal. 409–430. doi: 10.1016/j.ogc.2019.04.002.
- Wahyuni, D. (2020) *Kebidanan Komunitas*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Wahyuni, S. *et al.* (2023) *Buku Ajar Kebidanan Komunitas*. Edited by Science Techno Direct. Pangkalpinang.
- Wahyuningsih, H. P. (2018) *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Winda Agustin. (2023). Kolaborasi lintas sektor. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/71812/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>
- WHO (2017) "WHO | Women and gender equity." Tersedia pada: http://www.who.int/social_determinants/themes/womenandgender/en/ (Diakses: 31 Maret 2021).
- Zaenal, M. (2018) 'Implementasi Advokasi, Komunikasi, Mobilisasi Sosial dalam Program Pembangunan Kesehatan (Sebuah Tinjauan Teoritis)', 1(3)

F. Glosarium

AKI	: Angka Kematian Ibu
SUPAS	: Survei Penduduk Antara Sensus
ICM	: <i>International Confederation of Midwives</i>
PAK	: Panitia Antar Kementerian .
KIA	: Kesehatan Ibu Dan Anak
PKK	: Pemberdayaan Kesehatan Keluarga
POSYANDU	: Pos Pelayanan Terpadu
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
SIP	: Sistem Informasi Posyandu
KADARZI	: Keluarga Sadar Gizi
BUMIL	: ibu hamil
BUSUI	: ibu menyusui
Balita	: Bawah Lima tahun
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
LILA	: Lingkar Lengan Atas
ASI	: Air Susu Ibu
PMT	: Penyediaan Makanan Tambahan
PMTAS	: Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah
PUS	: Pasangan Usia Subur
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBAL	: Angka Kematian Balita
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
GKIA	: Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak

PROFIL PENULIS



Ummi Yuniyanti, S.ST., M.Keb Lahir di Pontianak, 21 Juni 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017, penulis bekerja di Rumah Sakit Yarsi Pontianak sampai tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis bekerja di Akademi Panca Bhakti Pontianak, dan berhenti pada 2022. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Aisyiyah Pontianak mengampu mata kuliah kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ummy@polita.ac.id



Bdn. Ratna Diana Fransiska, SST., MPH. Penulis dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 7 Agustus 1990. Editor adalah dosen tetap di Program Studi Sarjana Kebidanan, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan D-III Kebidanan dan D-IV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Malang. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret. Beberapa mata kuliah yang diampu yaitu Asuhan Kebidanan Remaja dan Pranikah, Asuhan Kehamilan Normal, Asuhan Pada Masa Menopause, Gangguan Sistem Reproduksi Wanita, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Beberapa karya telah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi diantaranya Analysis of Maternal Mortality Determinants in Bondowoso District East Java, Analisis Health Belief Model dalam Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Ibu Hamil, Minat Untuk Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Berdasarkan Pendidikan Dan Paritas, serta beberapa judul lain yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Penulis juga aktif mengembangkan ilmu dalam bidang kesehatan ibu dan anak dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan serta ikut aktif sebagai anggota dalam organisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia). Penulis dapat dihubungi melalui email: ratnadiana00@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Dr. Cut Sriyanti, SST, M.Keb Lahir di Meulaboh, 22 April 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan pendidik pada Program Studi DIV Kebidanan, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2007. Melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Program Doktor Matematika dan Aplikasi Sains (DMAS) pada Universitas Syiah Kuala Aceh dan lulus pada tahun 2023.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga bakti di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat sampai sengan 2003. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Aceh mengampu mata kuliah Askeb Neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, Askeb nifas dan menyusui, Askeb komunitas, KDPK, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, konselor menyusui, reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: cutsriyanti.mbo@gmail.com



Warini, S.ST., M.KM Lahir di Karanganyar, 27 Januari 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Prima Husada Tahun 2006-2009, D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon 2010-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2011 dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 di Akademi Kebidanan Prima Husada sebagai Dosen sampai tahun 2019

Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Ketrampilan Dasar Kebidanan I dan II, Mutu Layanan Kebidanan, Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: warini.supangkat@gmail.com

Motto: ""The journey of a thousand miles begins with a single step".

Sinopsis

Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan menghadirkan serangkaian pemikiran dan praktik yang ditujukan untuk memperkuat peran perempuan melalui pendekatan kesehatan, khususnya kebidanan. Buku ini dimulai dengan pemetaan tantangan global dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang disampaikan secara mendalam oleh Ummy Yudiantini. Dalam bab ini, pembaca diajak memahami kompleksitas isu kesehatan maternal di tengah dinamika global dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Bab selanjutnya menyoroti kekuatan pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam pemberdayaan kesehatan ibu dan anak. Ratna Diana Fransiska menjelaskan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya bidan, mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Studi kasus internasional yang disajikan memperkaya wawasan pembaca tentang bagaimana pendekatan lokal mampu menciptakan solusi global yang efektif. Buku ini kemudian berlanjut dengan pembahasan dari Dr. Cut Sriyanti mengenai peningkatan kesadaran kesehatan ibu hamil, yang mencakup peran edukasi, teknologi, dan dukungan sosial-ekonomi sebagai faktor kunci.

Sebagai penutup, Warini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat upaya pemberdayaan perempuan. Dengan memadukan perspektif kesehatan, sosial, dan kebijakan, buku ini memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya sinergi antar pihak dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan bukan sekadar buku ilmiah, tetapi juga menjadi cermin perjuangan dan harapan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan melalui peran strategis layanan kebidanan.

Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan menghadirkan serangkaian pemikiran dan praktik yang ditujukan untuk memperkuat peran perempuan melalui pendekatan kesehatan, khususnya kebidanan. Buku ini dimulai dengan pemetaan tantangan global dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang disampaikan secara mendalam oleh Ummy Yuniantini. Dalam bab ini, pembaca diajak memahami kompleksitas isu kesehatan maternal di tengah dinamika global dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Bab selanjutnya menyoroti kekuatan pendekatan berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam pemberdayaan kesehatan ibu dan anak. Ratna Diana Fransiska menjelaskan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan, khususnya bidan, mampu menghasilkan dampak yang signifikan. Studi kasus internasional yang disajikan memperkaya wawasan pembaca tentang bagaimana pendekatan lokal mampu menciptakan solusi global yang efektif. Buku ini kemudian berlanjut dengan pembahasan dari Dr. Cut Sriyanti mengenai peningkatan kesadaran kesehatan ibu hamil, yang mencakup peran edukasi, teknologi, dan dukungan sosial-ekonomi sebagai faktor kunci.

Sebagai penutup, Warini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat upaya pemberdayaan perempuan. Dengan memadukan perspektif kesehatan, sosial, dan kebijakan, buku ini memberikan gambaran utuh mengenai pentingnya sinergi antar pihak dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Bunga Rampai Pemberdayaan Perempuan Melalui Layanan Kebidanan bukan sekadar buku ilmiah, tetapi juga menjadi cermin perjuangan dan harapan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan melalui peran strategis layanan kebidanan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

